

● 써머리 사용법

- 19 줄준위 자료를 참고하여 만들었습니다
- 글자색의 의미는 다음과 같습니다

빨간글씨 기출 / 파란글씨 강조 / 회색글씨 교수님 여담 & 쌤부 첨언

들어가며...

Q. 일상에서 간과 관련된 것들은?

A-1. 속담

간이 크다 = 겁이 없다

간담이 서늘해진다 = 무서움을 느낌

간 떨어진다 = 무서울 때

간쓸개 다 빼준다/간에 붙었다 쓸개에 붙었다 = 좇대 없는 사람(심리적으로 편안X)

애가 끓는다 = 걱정이 많다 (애가 간에 해당)

A-2. 광고

간 때문이야~ = 피로

A-3. 음식

삼대진미 푸아그라(foiegras).

거위나 오리의 지방간. (foie=liver, gras=fatting)

이러한 용어들은 간 실제, liver를 의미하지 않음

겁, 무서움 등의 감정은 현대적으로 뇌에서 하는 작용

이러한 속담의 의미는 무엇일까?

- 과거 사람들은 정신사고에 대한 과학적 인식이 덜해
의식과 사고활동을 오장육부에 귀속시켜 만든 것일 뿐

따라서 간계내과에서는 간염, 간경화뿐만 아니라 철정과 관련된 것도 다루게 될 것!

제 1장. 간의 개론

제 1절. 의사학적 고찰

1. 내경에서의 간론

1. 소문 영란비전론

肝者, 將軍之官, 謀慮出焉. 膽者, 中正之官, 決斷出焉
간자, 장군지관, 모려출언. 담자, 중정지관, 결단출언

: 모려와 결단은 현대적으로 신경정신과 관련됨

모려: 어떤 깊은 일을 꾀하는 계략

2. 영추 본신

肝藏血 血舍魂 간장혈 혈사혼

肝氣 虛則恐 實則怒 간기허즉공 실즉노

: 혈에 혼은 없다! (*p.4 간의 생리 “간장혈” 부분 참고)

: 철정에 관련한 내용을 간에 배속

→ 중추신경계에 대한 과학적 인식이 부족했기 때문

→ 의식 사고 활동을 형상화하기 위한 노력이었던 것

3. 소문 오장생성론

人臥則, 血歸於肝 인와즉, 혈귀어간

: 간이 휴식과 피로해소를 관장한다

간수혈이능시, 족수혈이능섭, 장수혈이능약, 지수혈이능섭

: ~가 혈을 받아야 무엇을 할 수 있다, 즉 간이 활동력을 관장한다

+) 동의보감의 섭생법 “여름에 늦게 잠들고 일찍 일어나라, 겨울에는 그 반대”
현대사회와는 맞지 않는 이야기이나, 해가 있을 때 활동하라는 말

4. 소문 육절장상론

肝者, 罷極之本 간자, 피극지본

: 罷=피로

: 간은 **피로**를 주관한다

[소문 상고천진론] 칠팔간기쇠, 근불능동

[영추 위기실상] 50세 이상을 노인이라 정의

: 남자는 8*2세, 여자는 7*2세에 생식능력이 시작해 각각 8*8, 7*7에 생식능력이 사라짐(요즘에는 초경이 빨라지기도 하여 숫자는 큰 의미 X)

: 나이가 들면 근동작이 원활하지 못하고, 그 원인이 간기가 쇠하기 때문이라 이해

5. 소문 지진요대론

諸風掉眩, 皆屬於肝 제풍도현, 개속어간

풍병	외래지풍, 내생지풍(간풍내동)을 포괄
도	흔들리고 떨리는 것
현	어지러운 것

*현훈: 어지러움을 현훈(혹은 현모)이라 하지만,

→ 현은 암흑(눈앞이 자주 깜깜해진다)

→ 훈은 회전감(어지러움, 빙빙 돌)

→ 모는 혼미(멍하다, 땡하다)

6. 소문 육기진장론

시고풍자, 백병지장야

: 풍은 백병의 장(우두머리)이다

: 생리적 장은 좋은 의미겠지만, 여기서는 병리적 의미로 부정적 의미

: 풍병은 잘 낫지 않는다는 의미

7. 소문 자열편

간열병자, 소변선황, ~~

: **습열**에 대한 내용, 습열은 한의학적으로 염증 의미

2. 주요의학자들의 간병에 대한 인식 PASS

3. 한국의 간병사

- 일제강점기 이상화의 [이상화치료지침]

: 처방에서 약을 과감하게 70g씩 사용함

: 처방공부할 때 보면 도움되니 기회되면 읽어봐라~

4. 최근 연구 동향

1) 1990년대 들어 한약물의 **간 보호 기전**에 대한 연구 진행

: 세포사멸, 자멸에 관여하는 유전자 발현을 얼마나 억제하는가 연구

2) B형, C형 간염 바이러스 증식억제 등에 미치는 영향 연구(최근 관련 연구 감소)

: 95년 이후 출생은 간염 예방접종이 의무 → B형 간염 유병률이 떨어졌기 때문

: 현재는 **비바이러스성 간질환**(알콜 등)이 많이 발생하므로

주상에 활용되는 한약물이 알콜 대사에 미치는 영향 등이 연구되고 있음

3) 생성처방 연구

: 인진사령탕을 기반으로 1970년대 이후 만든 처방

: 생간건비탕, 생간탕, 인진청간탕, 인진사령탕, 청간건비탕, 청간해주탕

국시에서 “옳은 것을 고르시오” 문제에 이 처방들이 선지에 있으면 오답일 리 없겠지~

+) 최근 한약에 대한 안전성 연구 多

+) 지방간을 포함한 영양대사에 대한 연구

제 2절. 간의 개요

1. 간은 木之臟목지장이다

: 나무는 정지 없이 무럭무럭 성장함

: 간은 목기의 발생지기를 가짐

⇒ 간의 **활동력, 발생력**을 의미

[난경 41년] 肝有兩葉. 萬物始生, 草木甲折.

: 간에 양엽이 있다.

: 만물의 시생함에, 초목이 올라올 때 갑절의 형태를 띤다

[난경 42년] 左三葉 右四葉 凡七葉: 간이 7개의 엽으로 구성되어 있다

肝重二斤四兩: 간의 무게가 2근 4냥이다

간의 길이는 8자

: 간이 갑절*의 형태를 띠고 있어 간유양엽이라 표현함

*갑절: 떡잎이 둘로 갈라지는 모양

: 2근4냥은 현대 간의 무게와 유사(간은 우리 몸에서 가장 큰 실질장기)

: 1자는 30.3cm에 해당.. 그렇다면 간의 크기는?

: 과거와 현재의 도량형이 다름. **과거 사람이 해부를 했다는** 의미

왜 과거사람들은 간을 2엽/7엽이라고 했을까?

	冬	水(음중지음)
肝	春	木
	夏	火(양중지양)

1) 음중지음과 양중지양의 중간으로 음의 기운과 양의 기운을 모두 갖고 있음

→ 따라서 간유양엽이라 함

2) 서양의학의 해부학적 변이

① accessory lobe: 간이 기능적으로 정상이나 결체조직에 의해 나뉘어 보이는 것. 많이는 16개까지도 구획이 나뉨

② Riedel's lobe: 간우엽에서 소혀처럼 밑으로 빠져 늘어져 있는 것.

③ Cough furrow: 간에는 이상이 없으나 기침을 많이 하면 간 위의 횡격막이 자극되고, 자극된 부위에 groove가 생김. 많게는 6개까지 생기기도.

→ 해부시 변이가 있을 때, 과거에 간이 2엽, 7엽이라고 볼 수 있었겠구나~

2. 간은 風臟풍장이다

- 풍기는 성질이 好動流走 善行而數變 호동유주 선행이삭변

: 풍은 쉽게 병리적 상태가 되며, 간이 특히 풍에 쉽게 감동됨

: 풍병은 CVA(뇌졸중) 운동장애를 많이 일으킴

: 항진되어 진전, 경련이거나 저하되어 마비되는 것 모두 의미

- 풍병 치료에 주로 간경약이 사용된다. p.36(구판 55)

: 식간풍약을 많이 사용함 - 조구등, 백강잠, 방풍 강활 천마 등

: 평간 잠양 식품 등의 치료법을 사용

- 풍은 신경계 질환을 의미하기도 함

3. 간은 剛急之臟강급지장

- 인체를 방어 보호하는 장군과 같은 역할 (간자 장군지관~)

- 능동적이고 급한 성질

4. 간은 體陰用陽체음용양

체 = 음 = 구조적. 기질적 특징

용 = 양 = 기능적. 운동성과 기능을 포괄

: 간은 장혈의 장기이므로 **기질적 실체는 음**이고,

: **기능과 작용**을 보면 움직임, 화, 열과 관련이 있으므로 **양에 속한 것**으로 본다.

★ 간주소설의 6가지 기능을 쓰시오(19)

제 3절. 간의 생리

간기, 간양	기능적인 면, 특히 소설기능 위주
간혈, 간음	간의 기질적, 구조적인 면. 혈, 혹은 간장 자체

1. 肝主疏泄간주소설

- 소설은 升發승발과 透泄투설을 의미한다.

소	통함, 트이다	승발	올라가서 퍼진다
설	내보낸다	투설	사기를 내보낸다

⇒ 소설기능: 위아래를 소통시키는 기능

BUT 자기 멋대로가 아니라 간에서 조절하는 소통!

즉, 소설기능은 조절된 소통

양중지양 = 화 = 심 = 올라가는 성질 = 올라가서 퍼짐 → 승발
음중지음 = 수 = 신 = 내려가는 성질 = 사기를 내림 → 투설

- 수화부제: 화기는 올라가고 수기는 내려가 몸 안에 남는 것이 X, 유정, 도한, 정충 등의 증상
- 수화상제: 화가 약간 내려가 수의 투설기운을 줄이고, 수가 약간 올라가 화가 올라가는 것을 억제. 이것도 간의 소설기능

ex. 고암심신환, 구원심신환(심신이 같이 들어간 처방)

: 허로로 인해 수화가 조절되지 못하고 정충 도한 유정 제증에 사용
: 제중신편을 쓴 어의 강명길이 정조 세손시절부터 가장 많이 투여한 약이 고암심신환. 사도세자 일로 화를 내 수화부제 상태가 될 것을 우려했기 때문.
심연자음, 가미소요산 등도 많이 투여했는데, 모두 열을 내리고 성질을 죽이고 정을 보하는 약.

요약) 심-간-신. 간이 중간에서 위아래를 소통하는 역할을 했다는 거~~ 이게 소설기능이다!

1-1. 소설기능을 6개로 분류

① 기기의 조창

: 기의 순환을 돕는다.

: 인체의 기혈, 경락, 장부, 기관의 활동은 기기의 작용으로 수행되는데, 이는 간의 소설작용(추동력, 발생력)에 의해 영향을 받는다

② 정지안정에 관여

: 칠정의 정지활동이 어느 한쪽으로 치우치지 않게 조절해준다.

: 소요산이 여기에 해당함

*소요: 시경에서 나온 말로, 유유자적하게 걷는 것을 의미함.

③ 조양소화(비주승 위주강)

: 소화를 돕는다.

: 비위의 승강 분비 배설 소화를 돕는다.

④ 기혈순환에 관여

: 간장혈 심주혈 비통혈 폐흡청호탁 이런 작용을 모두 간의 소설 기능에 의해 만들어진다.

: 추동력과 간에서 갖고 있는 고섭력에 의한 것임.

⑤ 수액대사 조절

: 간 주관이 안되면 한산이 된다.

: 삼초의 통수도에 관여, 수액대사를 말함

⑥ 생식기능 보조

: 간신은 정혈동원 관계에 있으며, 간과 신은 같은 근본이다.

: 족궤음간경이 종근 쪽을 지나가므로 간에서 생식기능을 보조한다.

*생식기능의 주 역할은 신에서 함.

2. 肝藏血간장혈

[영추 본신] 간장혈 혈사혼: 간이 혈을 저장하고 혈에는 혼이 있다.

: 혼은 혼백인데, 정신 사유활동을 배속시키기 위함이고, 간에 혼이 있지는 않음.

- : 혈사혼은 대량출혈 시 쇼크상태가 나타나는 것을 혼이 빠져나간다고 본 것.
- 간장혈의 의미
- : 혈액을 저장해 **혈액량을 조절**하고 조혈*해 **혈액성분을 조절**
- : 혈액을 통한 영양공급이나 당질대사 등도 포함
- : **출혈방지**의 뜻을 포함; 간이 피브리노겐이나 프로트롬빈 등을 만든다는 것이 근거
- : 체내 혈류를 조절해 **체온유지**도 함

*조혈은 어디서 하나?

- 태생 6주까지는 간성 조혈
- 태생 12주까지는 비성 조혈
- 이후 골수에서 조혈을 담당

골수가 조혈을 못하는 상황이 되면? 나이를 먹거나 대량출혈 등 특수한 상황.

- spleen이나 lymph node에서 조혈을 담당하게 됨.
- 이를 **골수양화생**(골수처럼 변한다; myeloid metaplasia)이라 함.

3. 肝主風木氣간주풍목기

- 제풍도현 개속어간
- : 외풍, 내풍에 감촉되지 않게 방어함
- 간은 풍목을 주한다
- : 간은 풍기를 갖고 있으므로 **풍기를 조절 가능**하다는 말

4. 肝主간주모려

- 춘기는 잠발미맹
- : 싹이 트지 X. 뱉어내지 않고 머리 속에 계락이 숨어져 있다, 모려가 그렇다
- **간은 모려출처**(모려가 나오는 곳)로서
- 인체를 정상으로 유지하고, 사기를 방어하는 **복잡한 대사활동**을 한다

5. 肝藏魂간장혼

- 간장혈 혈사혼을 줄인 것
- : 기억회상, 새로운 아이디어 등 뇌에서 하는 정신활동을 담당한다?
- : 과거에는 뇌를 기항지부로 도외시하고 잘 몰랐기 때문에 간에 넣어둔 것임

6. 肝主筋간주근

- 간자 기충재근 / 간지합근야 / 간생근
- : 근이 간으로부터 자양을 받아 생한다는 말
- : 근은 단순 근육만이 아니라 건을 포함한 근막, 관절, 기육 등 의미
- : **간이 인체 운동을 담당**한다는 의미
- 간자 피극지본
- : 간은 운동을 담당해 **피로를 조절**한다.

7. 肝主爪간주조

- : 손톱은 근지여

8. 肝主目간주목

- 간주목 간개규어목
- 간수혈이능시. 목수혈이능시
- : 간은 눈을 담당한다

9. 肝主淚간주루

- : 간은 눈물을 담당한다

- 간의 기능이 매우 다양해 화학공장과 유사하다
- 간의 기능이 매우 복잡하다

- 간은 3/4이 절제되어도 기능이 가능하고 재생하기도 한다.

제 4절. 간의 병리

1. 간병의 병인

★간병의 원인 중 외인에 대해 기술해라(10)

1. 외인

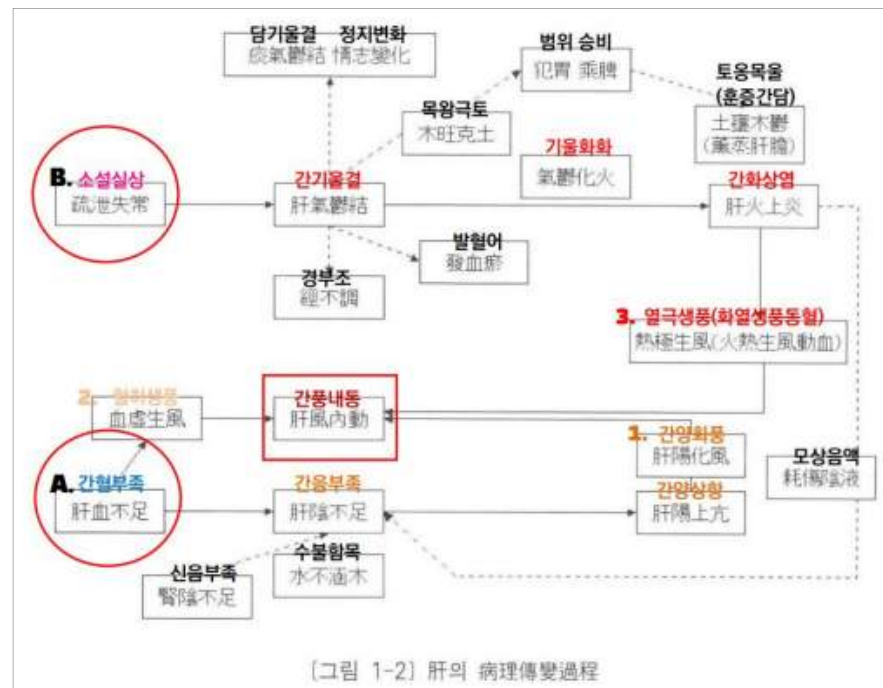
1) 六淫육음

① 風풍

- 간풍은 내풍의 범주에 속함, 풍기가 간에 통하므로 외풍과 간병의 관계도 밀접

- 간병의 병리전변과정 3가지(사진출처: 19 졸준위 자료)

★간 병리전변 과정 괄호내용(소설실상, 간혈부족)



섭천사 曰: “혈허→수불함목(음허)→양항→간풍내동”한다.

간혈부족 (장혈기능 실조)	→ 간음부족	→ 간양상항	→ 1. 간양화풍 → 2. 혈허생풍	⇒ 간풍내동
소설실상 (소설기능 이상)	→ 간기울결	→ 간화상염	→ 3. 열극생풍	

- 풍은 陽邪양사로 善行而數變선행이삭변한다.

: 지난시간 간풍을 없애기 위해 식풍약류를 사용한다고 함

: 중풍이 '1. 간양화풍의 병리전변과정'에 해당할 때, 진간식풍탕을 많이 사용한다.

+) <성향정기산>

- 중풍에 가장 많이 사용하는 처방
- 곽향정기산 加 남성 목향
- 적응증: 中氣중기, 中風중풍, 痰厥담결, 食厥식결
- 방약합편 曰: 먼저 이 처방을 1~2첩 사용한 후 正氣其後 後證加減 정기기 후 후증가감한다. (여기서 氣는 風氣를 의미)

Q. 正氣정기가 무엇일까?

A. 기를 바르게 한다? (X)

선행이삭변하는 풍기를 관리하기 편하게 잡아두는 것(O)

ex. 교실 속 돌아다니는 파리(풍기)는 잡기 어려우나, 물병이나 칠판 등에 붙어있으면(정기) 잡기 편해짐.

→ 오약순기산, 목향순기산의 의 '순기'도 마찬가지

⇒ 기와 관련된 치법인 정기, 순기, 조기는

“풍기를 잡아 처치하게 편하게 만들어주는 과정”을 의미함

BUT 교수님이 중풍환자에 성향정기산을 사용해서 실패했던 case

: 90대초 펠로우 시절, 반신불수 환자가 입원해 '중풍엔 성향정기산이지!'하며 처방을 내림. 쓸 때마다 증상이 호전되어 2주 정도 투약 후 퇴원 조치를 내리려 했는데, 호흡곤란이 오고 불편해져 응급실에 갔다가 결국 사망

Q. 성향정기산에 어떤 문제가 있었을까?

A. "정기기후 후증가감"이라 했는데, 너무 길게(2주) 사용했다는 것.

성향정기산 구성 약재들은 기가 약, 이기약이 많음. 기가 약은 몸을 '말린다'. 원래 몸에 혈허나 음허가 있는데 기가 약을 지속투여하면 말라있는 몸에 계속 말리는 약을 투여하는 것이므로 문제가 발생하게 됨. 해당 환자도 나중에 알고보니 협심증이 있었다는 사실,,

+) '매핵기에 가미사철탕'이라 하지만, 이 처방 역시 대부분 말리는 약으로 구성되므로 혈허, 음허한 사람이나 평상시 몸에 열이 많은 사람에게는 부작용이 날 수 있음.

⇒ "특정 약에 특정 약이 잘 듣는다" 이것이 위험할 수 있다는 것!

+) <방약합편의 특징>

- 한의사들이 가장 많이 보는 처방집으로, 상중하로 나뉘어 있음

상통	보익하는 약재 위주	익기보혈탕	보기 익기 순기
중통	화해시키는 약재 위주	삼소음 패독산 소시호탕	정기 이기 조기 순기
하통	공벌하는 약재 위주	오령산 방풍통성산	강기 하기 파기

: 성향정기산의 정기는 중통에 해당하는 치법임

: again 선행이삭변하는 풍기를 잘 잡기 위해 정기, 순기의 치법을 사용한다

② 火化, 熱열

- 陽邪양사로 풍의 성질과 비슷해 풍과 어울려 질병을 형성하는 경우가 많다.

③ 寒한, 濕습

- 陰邪음사로 응체성이 강해 승발, 소설 등의 작용을 견제하여 간의 생발지기를 저해한다.

- 풍과 잘 어울리지 않으나, 체내에서 생기는 한사나 습사는 간과 어울려 다시 질병을 일으킬 수 있다.

2) 癰氣려기

- 전염력이 아주 강하고, 신속히 발생

- 외사가 불결한 환경 속에 침입하여 발생

- 가장 흔한 것이 A형 간염(불결한 환경, 수인성 전염병), 그리고 E형 간염

- 한의학적으로 疫癰發黃역려발황(황달의 일종), 急黃급황(전격성 간염)

- 肝癰간옹은 서양의학적으로 간농양에 해당

2. 내인(=칠정)

- **怒노 위주. 恐공, 憂우, 驚경** 등도 소설기능 실조를 야기해 간병을 일으킴
 <소문 음양상대론> “노기가 간을 상한다”
 <생기통천론> “노즉기상”
 소원방의 虛勞候 “대노하여 기억하면 상간한다”
 大怒氣逆則 形氣絕而 血鬱於上 使其人(薄厥박궐)
- 기가 상역하면 승발 소설 작용이 태과하여 혈지여기, 병주어상하여 궐, **박궐증**을 일으킬 수 있다.
- 간의 장혈기능이 영향을 받을 시 위로는 두혈, 아래로는 봉루하게 된다.

여택지 11p. <박궐증>

- 원인: 대노기역
 : 식도정맥류 출혈과 유사
 : 간의 침습적 만성질환, 간경변 말기에는 식도 안쪽의 정맥이 내시경으로 보일 정도로 노출됨. 단단한 음식을 먹는 등 정맥에 상처가 나면 대량출혈이 일어남
- 증상: 인소무병(원래 병이 없다가...)
 : 병이 없는 것이 아니라, 간은 “침묵의 장기”로 매우 심각한 정도가 아니면 간으로 인한 증상은 잘 나타나지 않음
 : 병이 없는 것처럼 보이다가 대노하거나 과한 스트레스를 받아 토혈을 엄청 많이(반되) 함
- 치료: 지혈 소간 이기

<怒傷肝노상간의 현대의학적 해석>

: 스트레스 상황 노출 시, 자율신경계 H까지 영향을 받아 간조직 손상을 악화 시킴

3. 불내외인

- 1) 酒食不節주식부절
 - 술은 가장 **습열**한 성질을 가짐
 : 술의 성질은 대열 대한 대습 유독
 - 과량 섭취 시 어지러움, 두훈, 구토 등을 유발
 : 간의 승발, 동요기능을 지나치게 항진시키기 때문
 - 비위 습열이 정체된 것이 간담으로 이동해 **간담습열병상**을 일으킴

207p. 알콜의 간 대사 및 간 손상기전

★ADH, MEOS에 대해 설명해라(15)

Q. 술은 마시면 는다?

A. 알콜을 분해하는 것은

→ ADH알콜분해효소, MEOS알콜분해시스템, catalase

catalase는 알콜 분해에 1% 미만으로 작용하므로 제외

→ 알콜 분해에 ADH:MEOS가 8:2로 작용함(소주 2병만 마시면 ADH가 2병, MEOS가 2병)

→ 술을 먹다 보면 ADH는 그대로이지만 MEOS가 50%까지 올라감(ADH가 2병, MEOS가 2병)

⇒ 술을 마시면 느는 것이 맞다!

but 분기별로 술을 먹거나 원래 몸 안에 ADH가 적은 사람은 술을 못 먹음

2) 房勞방로

- 방로가 무절제하면 신에 손상이 가고, 간까지 손상됨: 肝腎同原간신동원
- 肝陽上亢간양상항
 : 용어는 실증같지만 그 base는 간음부족 (간음부족→간양상항→간양화풍→간풍내동)
 : **본허표실증**
- 女勞瘵여로달을 일으키기도 함
 : 황달전구기에 과도한 방로, 성접촉 시 바이러스 감염으로 나타나는 간염

3) 勞役過多노역과다

- 간은 罷極之本피극지본
- 노역과다하면 傷筋傷肝상근상간하여 간병이 발생

4. 외상/기타 PASS

★간병 전변에 대해 기술해라(12)

2. 간병의 전변

기질적 문제	간질환, 쓸개질환
기능적 문제	소설기능, 장혈기능의 문제
	만성피로증후군도 해당
	신경정신과적 문제
	: 결단과 모려가 안 되어 나타나는 정충, 경계, 불면 등
	신경계 문제: 간풍내동으로 나타나는 중추&말초신경장애

- 병상(가볍게 넘어가심. 19써머리 참조)

실증	소실실상으로 나타나는 병
허증	간혈부족, 장혈기능 실조로 나타나는 병
정신신경과적	심지, 정지변화
제품변증	
근맥불리	만성피로증후군

1. 소설기능의 실조

1) 肝氣鬱結간기울결

- 분노 등 **칠정에 의해 소설기능이 실조**되어 험창통, 소복창통이 나타남
 <영추 본신편> 간기허즉 쯔공하고 실즉 實실한다
 <소문> 간혈부족즉 쯔공하고 간혈유여즉 實실노한다
 → 간기울결이 있으면 정지변화가 나타난다는 말
- 소요산, 시호소간상 등 처방 사용
- 노기가 상역하면 대궐을 일으키게 된다(→박궐증)

2) 담즙의 분비, 배설 이상

- 비위기의 승강작용이 장애를 받아 소화 흡수 배설에 관련한 병리현상이 발생
- 비주승 위주강이 안됨

① 간위불화 肝氣犯胃간기범위

- 울결된 간기가 횡역해 위기를 하강하지 못하게 하는 병리현상
- 위완창통, 구역, 애기, 탄산 등의 증상 + 간기울결 증상

② 간비불화 肝氣乘脾간기승비

- 간기가 횡역승비하면 비기가 상승하지 못하는 병리현상
- 복창, 복통, 복명, 설사 등의 증상 + 간기울결 증상
- 한의학의 비는 서양의 intestine에 해당

③ 습열로 이해

- 담즙정체, 담즙색소 대사장애로 황달, 구고, 구토황수, 불사식 등의 증상
- 1) 간기승비로 운화작용이 약화되어 생긴 습이 열이 되어 습열상박
- 2) 습이 간기울결로 생긴 열과 함께 간담에 정체되어 나타나는 습열의 병리변화

④ 간의 소설기능실조로 기기가 불창하면 삼초 수액대사 장애

- 수종 복수 등 증상까지도 발생

<습열>

- 습열은 병리현상이다
- 저수지에 물이 잘 들어오고 나가면 저류되는 것 없이 내부 물이 깨끗할 것
If 들어오는 길 or 나가는 길이 막히면?
저류현상이 생겨 저수지 안에 정상적 수액대사가 일어나지 못하고 녹록해진 다(점도가 높아진다).

- 이렇게 정체되어 나타나는 병리현상이 습
- 고인 물이 오래되어 이물질이 생기는 것이 담
- 담이 생긴 상태에서 저류 상태가 더 지속되면 열, 열을 감염상태라 봄

- 간담도 질환에서 습열을 어떻게 하느냐가 중요

- 습 조절에 많이 사용하는 처방은?
: **오령산**(택사 저령 복령 백출(창출) 육계)
: 육계를 제외하고 모두 습을 조절하는 약재 (오령산-육계=사령산)
- 택사: 호숫가 식물로 물을 살람이며 움직임. 움직이는 습을 조절
- 백출(창출): 고정된 습을 조절
- 복령: 소나무 뿌리 속 균체로 깊은 곳의 수분을 조절
- 저령: 단풍나무류의 뿌리 균체로 얕은 곳(낮은 곳)의 수분을 조절
- 오령산은 체표~심부, 움직~고정까지 모든 수분을 조절하는 약

Q. 육계는 왜 들어갔나?

A. 습을 조절한다는 말은 습을 뺀다는 말.
장기간 습을 빼면 신양허가 발생하는 것을 우려해 육계를 가미한 것이다.

+) 심미도적산도 도적산의 변방으로, 심열을 꺼뜨리는 차가운 약재 위주로 구성되어 있음. 너무 차가워 중한증에 걸릴 것을 우려해 따뜻한 약인 반하가 들어가 완충작용을 함

+) 상한방은 보거나 사하 등 한쪽에 치우친 처방이 많은데, 후세방은 이를 완화시키기 위해 **완충재**가 들어간 처방이 많음. 오령산도 그 일종이다!

<백출과 창출>

- 건비조습하는 약: 건비>조습=백출, 조습>건비=창출
- 앞의 방약합편 분류에 따르면 백출은 상, 창출은 하에 해당
- 백출과 창출은 같이 사용하는 경우가 드무나 몇몇 처방에서 사용
- 방약합편 중통 향사양위탕
 - 주치증: 심하비(소화X), 불사식(밥맛X)이 胃寒위한 때문에 나타날 때
 - 활투: ①불사식이 심하면 백출을 군약 ②심하비가 심하면 창출을 군약
- ⇒ 무엇을 군약으로 쓸지는 의사가 결정해서 사용해야 하는 것이다!

3) 기기불창으로 음양기혈이 문란

① 장혈기능에 영향
- 심하면 혈액이 어결되어 징가 적취 비괴 등 증상
② 간화상염
- 간기울결되어 기울화화하면 간화상염이 일어남
- 두통, 현훈, 목적통, 이명, 토혈 등 상부 증상
- 본과 표 모두 실한 본표개실증 (본허표실증인 간양상향과 구분)
→ 더 심해지면 화열이 생풍하는 열극생풍
③ 간양상향
- 화성하면 간음을 상해 간양상향이 일어나 간양화풍하게 됨
- 본허표실증
- 간음부족으로 인한 간양화풍, 혈허로 인한 혈허생풍은 간풍내동을 나타냄
- 근맥운동불리와 관련된 신경마비 증상, 모혈, 동혈해 토혈, 육혈 등의 증상

2. 간기부족

- 간의 정기가 부족한 것
- 근맥실양, 활동둔화, 피곤무력, 실면, 정신억울 등의 증상
- 익기보혈탕류의 처방을 많이 사용함

3. 장혈기능의 실조

- 간혈부족, 간혈허한 것
- 현훈, 면색무화, 안정건삽, 지체마목 혹 근맥구급, 월경량소 혹 경폐 등 증상
 - 혈이 눈을 영양하지 못하면: 안화, 목건삽, 야맹
 - 혈이 귀를 영양하지 못하면: 이롱, 이명
 - 충임맥에 혈이 부족하면: 월경량소, 심하면 경폐
 - 이상출혈: 월경과다, 붕루
 - 혈이 근을 영양하지 못하면: 근통, 근맥구련, 지체마목, 굴신불리 등 운동장애

① 간풍내동

- 앞 내용과 동일. 그림으로 확인하세요

② 간의 장혈실조로 소뇌활동에 영향

<소문 영위생위편> 혈자신기야

- 혈허이면 경계, 정충, 불면, 실면 등의 정신 증상이 나타날 수 있음
 - 대량출혈 시 쇼크증상, 섬망, 혼수 등이 나타날 수 있음
- ⇒ 과거 사람들이 정신상태와 혈이 관련있다고 생각한 것!

③ 간의 장혈실조 → 간혈부족 → 간음부족 → 간양상항 (앞 애기와 동일)

- 전제는 간음부족! 실증같지만 본허표실증이다

+) 간음부족으로 간양상항할 때 두 증상이 동시에 나타나야 하지만 하나만 주로 나타날 수 있음

: 임상에서는 주로 간양상항만 보이는데, 환자가 양증 호소를 더 많이 하기에 표가 나는 것

→ 간음부족으로 혈허, 음허하면: 저혈, 도한, 한출 등

→ 간양상항으로 편어양항하면: 정신흥분, 이노(쉽게 노함), 두통, 두창, 목적, 실면, 심계, 요산(허리 저림), 각연 등

⇒ again 외면상으로 표실증이나 음허를 전제로 본허표실임을 항상 유의

4. 제풍도현 개속어간

- 간은 풍병과 밀접한 관련이 있다. 고혈압, 중풍 등이 해당함
- 생혈부족, 출혈과다(간혈부족)로 혈허생풍하면 사지마목, 기육경축 등 증상
- 노동이 심하면 근이 상해 전근, 근통, 근무력 증상
- 혈허생풍해서 기능저하가 되는 경우 장기간 근운동장애가 있게 됨

① 간풍내동으로 근운동장애

- 추혹, 마목, 진전, 반신불수, 구안와사 증상
- 간양화풍, 열극생풍, 혈허생풍의 병리적 과정을 거쳐 발생
- 간양화풍은 CVA, 벨마비 증상과 유사

② 열극생풍으로 근운동장애

- 추혹, 사지구급, 각궁반장(몸이 뒤틀림) 증상
- 주로 체간성 운동장애로 파상풍, 열성 급경풍 등이 해당

③ 혈허생풍으로 근운동장애, 피부증상

- 양하지근무력, 피부건조, 아토피 등
- 오래된 병으로 간혈이 허해져 영양을 받지 못해 나타남

<양하지근무력=하지불안증후군>

- 성인 남녀 7~8%에 발생
- 잠자리에 누우면 다리에 벌레가 기어다니는 듯한 이상감각장애
- 치료: 보혈, 30분쯤 돌아다니다가 눕기

5. 기타

① 간기부족으로 근맥이 실조

- 피곤무력하며 활동이 둔화되는 증상.

② 간양이 허해 근맥불리

- 간양의 승발이 부족해 외한지냉, 근맥구급, 음낭수축 증상

③ 외한이 족궤음간경에 침입해 기혈이 응체되어 종근 부위에 한증

- 간경이 지나가는 음부 부근에 소복창통, 음낭수축, 근급, 근련 등 증상
- 이때 난간전을 사용
: 구기자(찬 약)가 군약이나 그 귀경이 간신이고, 소회향과 육계로 한증을 몰아냄

6. 간담은 표리지관으로 습열사가 간담에서 蘊蒸온증되어 병변 유발

- 협늑만민, 동통, 발열, 구고, 오심구토, 복창염식, 변비, 황달, 소변황적 등 간담습열증

습열을 일으키는 4가지 기전

- ① 時邪시사가 외습해 습사에 감축되어 오래되면 化熱화열(습생담 담생열)해 간담습열
- ② 기름진 음식, 끈끈한 음식을 오래 먹어 음식부절, 주독으로 습탁이 생성되어 열이 발생
- ③ 간기울결이 오래되어 氣鬱化火기울화화해 습열

④ 노권내상하거나 본래 비기, 비양이 약해 운화작용을 잃고 습이 조체되고 鬱而化熱울이화열한 열과 만나 간담습열

- 간담습열이 간경맥을 따라 전음 주위로 가 음낭습진, 고환이 붓고 열리는 증상
: 한증에는 난간전을 사용하는데, 여기서는 습열증상이므로 용담사간탕류를 사용

↔ 외감한사가 족궤음간경을 침입해 소복 및 음부에서 기혈이 응체되어 소복근 창통, 고환이 커지고, 음낭 수축 등의 증상
: 추우면 증상이 심해지고 따뜻하면 나아진다

제 2장. 간병의 증치

제 1절. 개요

간병은 주로 소설기능, 장혈기능 실조로 나타남

소설기능 실상	실증
장혈기능 실상	허증
외감사기, 습열사에 의한 것	간양상항은 본허표실증
	실증

BUT 임상에서 병리과정은 복잡하게 엉켜서 나타나므로 변별하기 쉽지 않다.

즉, 환자는 책대로 아프지 않다!

- 망문문절 중 무엇에 가중치를 두어 환자를 볼지 정해야 한다.
- 경험을 쌓고 많이 접해보며 변별하는 연습이 필요하다!

1. 頭痛두통

1) 肝鬱頭痛간울두통

- 동의보감 육경두통에서

소양경두통	- 머리 편측으로만 통증 - 인경약으로 시호, 황금 사용
양명경두통	- 미릉골, 앞머리에 통증 - 인경약으로 백지, 승마, 갈근, 석고 사용

→ 간계내과에서는 편측두통, 미릉골통, 흥협창만한 증상을 간울두통이라 함

2) 肝陽頭痛간양두통

- 頭暈目玄두훈목현하면서 이명 증상(간음부족)이 있고, 간양상항이 나타나는 것

3) 肝火頭痛간화두통

- 심번목적, 구고이노 뇨황 등의 증상은 간울화화한 것

4) 肝寒頭痛간한두통

궤음경두통	- 정수리, 두정부에 통증 - 인경약으로 오수유 사용
-------	----------------------------------

→ 간계에서는 간한두통이라 함

5) 血虛頭痛혈허두통

- 현훈, 안면창백, 오심, 오후에 증상이 심해지는 것은 간혈부족한 것

• 허증두통의 분류

기허두통	오전에 심함. 무열. 쏟아지는 듯한 통증. 당귀보혈탕
혈허두통	오후에 심함. 저열. 눕기 좋아함. 순기화중탕

2. 眩暈현훈(眩冒현모)

현	암흑, 눈앞이 깜깜
훈	회전, 머리가 빙글빙글
모	혼미, 머리가 멍/땡

- 풍 화 담 허로 인해 나타남

- 동의보감에서 육종현훈으로 나누나 간계의 분류와는 다른 주의

3. 협통, 협만

- 옆구리의 통증
- 한의학적 원인: 기울
- 외사 또는 칠정에 의해 간이 손상을 받으면, 기가 응체되어 통증이 발생
- 현대의학적 원인: 비장종대, 대상포진, 늑간신경통, 늑골타박상, 장내 가스 등
- 동의보감에서 육종협통(5 실증/1 허증)을 다루나 간계에서는 기울협통을 말함

기울협통	통증이 있기도 하고 없기도 하다가 점차 심해짐
어혈협통	통처 고정, 바늘로 찌르는 듯 아픔, 야간에 증상이 심해짐

4. 소복통

- 소복은 간경에 속하는 부위
- 기체는 통증이 심하고 脹症창증*을 겸해 나타남

*창증: 종근 부위가 脹창하다

5. 정지변화

- 간기가 울결되었을 때 善太息선태식(한숨을 많이 쉬)
- 억울된 감정, 의심 걱정이 많음

cf. 교수님 아는 직원은 술로 스트레스를 풀다가 근무시간에도 먹어 알콜 중독 진단을 받기도,, 스트레스 해소 방법에 대해 생각해보기

6. 口苦구고

- 간양상향, 간화상염되어 건조해진 것
- 간에 열이 있어 담즙이 外泄외설(넘쳐흘러, 즉 역류)하여 나타남
- 역류성 식도염, 역류성 후두염
- 구고 뿐만 아니라 咽苦인고(목구멍에서 쓴맛이 남)
- 한의학적으로 매핵기에 해당

7. 출혈

- 간이 장혈기능을 잘 하지 못해 발생

8. 안목증상

- 간개규어목

간음부족	양목건삽
간혈부족	야맹증. 보간사물탕(사물탕+강활 방풍) 처방

9. 이명 이롱

- 이비인후과 내용임. 귀가 간담경이 지나는 부위로 이해

실증	- 이명이 潮水조수(파도소리)와 같음
실열증	- 손으로 눌렀을 때 이명이 더 크게 들림 - 간화상염으로 발생
허증	- 이명증이 장시간 유지됨, 매미소리처럼 들림 - 손으로 눌렀을 때 이명 크기 감소

cf. 간계에서 이명 이롱이 주소증인 환자를 볼 일은 없고, 다른 주소증을 이야기하다가 이명 이롱을 부가적으로 이야기하는 경우가 있음. 교수님은 이명 이롱 치료가 가장 어려운 거 같다 하심,,

10. 瘰癧麻木축경마목

축	사지가 오므라드는 현상
경	각궁반장, 근맥구급

- 간풍내동하여 나타남

간양화풍	간양이 상향해 지체가 마비되거나 떨리는 현상
열극생풍	고열로 풍이 생겨 정신혼미, 항강증, 각궁반장(허리가 뒤로 젖혀짐)
혈허생풍	간혈허로 손등, 손가락이 저림. 야간에 심해짐

11. 疝氣산기

- 간경맥이 전음을 지나 돌기 때문에 발생

12. 월경부조

- 간의 장혈기능 때문에 발생

13. 한열왕래

- 혈허하거나 간담의 기가 울체되어 나타남

병세 완만, 병정 깊 (내인)	- 기혈과 음양이 조화가 상실되어 발생 - 보음익기하는 처방
병세 급, 병정 얕음 (외인)	- 외사가 소양의 반표반리에 침입 - 소시호탕 사용

14. 황달

- 비위의 습열이 간담을 횡역(침범)하여 나타남
- 습타이 원인으로 비위운화기능이 실조되어 설태후니, 음식무미, 구토 등의 증상

15. 창만

- 간 비 신이 손상되어 나타나는 것, 뒤에 다시 나올 것이라 PASS

16. 프로

- 간은 罷極之本 피극지본
- 만성피로증후군: 6개월 이상 **설명이 되지 않는** 피로가 지속적으로 나타나는 것

cf. 본과 3학년에 올라와 피곤한 것은 설명이 되는 피로겟조? 만성피로증후군이 아님

⇒ 이 16가지 증상이 모두 동시에 나타나는 것이 아니라 1개, 혹은 2-3개씩 겹쳐 나올 수 있음. 즉 임상에서는 환자의 증상이 복잡하게 나타나므로 각 증상의 경중과 현상을 살펴 주증 차증 겸증을 판단해야 한다.

- 경증을 표현하는 방법: NRS, VAS
- 워대하병원원 가계내과에서 사용하는 초진차트 예시

전		교		의		성		실	
학급: /		학번:		학종:		학/영구자: /			
전신명									
주소명									
산원급진	☐ 원 ☐ 진 ☐ 연중								
한방적						통증합가 음부 ☐ 음 ☐ 음 부위 강도 KRS 양상 ☐ 좌완는듯한 ☐ 등완는듯한 ☐ 좌완는늘 ☐ 좌시로는늘 ☐ 좌는듯한느림 ☐ 등근발 ☐ 기타 ☐ 특이증상			
과거력	☐ HTN ☐ DM ☐ HL ☐ HD ☐ TB ☐ 기타								
가족력						병력 ☐ 자식력 ☐ 간담력 ☐ 결혼력 사후 사망			

원광대학교 한방병원

우측 하단: 통증의 양상을 잘 기록해 재진 시에 경과를 잘 확인할 수 있음

• 肝痺證간비증(厥證醗증)

- 폐병이 간으로 전이된 것
- 헝통, 吐食토식하는 증상

• 간의 외증과 내증

외증	善潔선결 面靑면청 善怒선노 등 증상
내증	배꼽을 누르면 아프고 복대창만 소변임습 등 증상

- 과거 국시 출제 문제였으나 최근에는 잘 나오지 X

• 간의 실증과 허증

간실	양협하에 통증, 소복통증, 쉽게 화를 냄
	간병이 처음 일어날 때는 실증이 많다; 기화가 유여하거나 습열병리가 나타나기 때문
간허	소설실상은 주로 실증
	눈이 안 보이고 귀가 안 들리고, 쉽게 두려워하며 누군가 잡으려 오는 듯 쫓긴다(如人將捕之여인장포지)
	→ 인숙산仁熟散 처방
	허증은 주로 간혈, 간음부족으로 인해 나타남
	장혈부족은 주로 허증

★ 간병의 변증논치 요점을 써라(11 재시)

• 간병의 변증논치 요점

① 간병은 주로 上盛證상성증이 많다

: 소설실상에 의해 간화, 간울로 기울화화하는 증상이 많기 때문이다.

② 標표가 실증이라든가 本본이 허한지 살펴야 한다

: 본허는 주로 간음부족으로 인한 干양상항(본허표실증)이다

③ 上盛상성되는 경우,

본허(X) 표실(O) 하면	- 청간사화법 사용
본허(O) 표실(O) 하면	- 음허양항 - 자음평간잠양법 사용

④ 칠정소상의 간병에는 약석(약과 침)의 효능에만 의존하지 않고, **감정의 절제가 필요하다.**

임상 case

60대 중반 여성, 불안, 경계, 정충, 불면, 안면홍조를 주소로 함. 남편이 퇴직한 1년 전부터 증상이 지속됨. 소요산 처방했으나 효과 없었고, 사실 콜라텍에서 춤추는 것이 취미인데 남편 퇴직 이후로 취미활동을 할 시간이 없어 병이 된 것임. 남편에게 부인과 함께 취미활동을 하라 했더니 증상이 모두 개선됨. 칠정소상에 의한 간병에 해당하는 케이스

⑤ 血虧腎虛혈허신허에 의한 간병은

: 신체를 배양해 점진적으로 회복을 도모해야 함

: 외감풍사나 기순행장애, 비위불운은 습증이 되어 실증에 속하므로

→ 疏肝理氣 소산이기 內消내소시켜야 함

- ★ 간실증과 간허증에 대해 서술하시오(15)
 ★ 간실증에 대해 아는 대로 써라(05, 08, 10, 11, 13, 17)

제 2절. 실증

1. 간울(간기울결, 간기불서)

- 병인: 고뇌와 분노로 소설기능이 실조하여 나타남
- 증상: 양협창통 유방창통 + 애기 식욕부진 구토 설사
 스트레스 받아 생기는 증상 + 소화기계 증상
- 스트레스성 질환, 만성담낭염, 유방 관련 질환으로 나타남
- 치법: 소간이기.
- 처방: 시호소간탕
 /생간건비탕, 청간건비탕, 인진청간탕, 청간해조탕(1980년대 이후 만들어진 처방)
- 간기가 울결해 오래되면 간기울결 기체혈어 간기범위 간기승비 등을 일으킴

1) 간기울결(매핵기)

- 병인: 간기울결로 비위운화기능이 약해져 습, 담이 생성→목구멍이 막힌 듯함

한의학	매핵기. 객불출 연불하; 삼키려 해도 삼켜지지 않고 뱉으려 해도 뱉어지지 않음
서양 의학	히스테리 구球 한국표준질병사인코드 F458-03 심인성 히스테리를 동반하는 삼킴장애

- 신경성 질환 만성 인후염, 식도염
- 치법: 이기화담.
- 처방: 반하후박탕, 가미사칠탕

- 반하후박탕: 매핵기, 후비루(코가 자꾸 뒤로 넘어가는 증상)에 활용, 보험약
- 가미사칠탕: 매핵기에 성약 이라 하는데 교수님은 딱히..

→ 부작용 case

- : 86년도 교수님이 본3 때 친구 어머니가 놀러와서 매핵기 증상이 있어 가미사칠탕 처방을 냈다가 부작용이 남.
- : 가미사칠탕과 반하후박탕의 구성약재들은 모두 기가약, 말리는 약들임
- : 특히 주재료가 반하인데, 반하의 성질은 따뜻하여 寒痰한담을 치는 약임
- : 태음인열증 환자였는데, 가미사칠탕을 주니 안 맞았던 것.

→ 열이 많은 사람에게는 수치를 해서 반하를 상외관계인 생강에 버무려서 사용함

- +) 반하 들어가는 처방: 자음건비탕
- : 기혈허하면서 담음으로 인한 현훈에 사용
- : 건비는 조습의 의미가 있는데, 자음과 조습은 상충하는 개념으로 자음과 건비를 동시에 하는 것이 현실적으로 어려운 처방
- : 교수님께서 많은 책에 자음건비탕이 있는게 의아하다고 하심

2) 간울기체혈허

- 병인: 간기울결이 오래되어 기기불창하여 발생
- 증상: 간기울결 증상 + 어혈 증상(: 면색칙칙, 형체 마름, 설자, 설변어반*)
- *설변어반은 원래 있는 사람도 많으니 이것만으로 어혈 증상이라 보기 어려움
- 간비종대가 있는 만성 간염이나 복부 종괴
- 치법: 이기활혈화어.
- 처방: 격하축어탕(어혈에 초점), 시호소간음(간기울결, 간기체에 초점), 생간건비탕(간 실질에 초점)

★ 각각을 비교하여 서술하시오(13, 14, 19)

3) 간기범위(간위불화)

- 병인: 위주강이 안되어 나타남. 한의학의 위는 서양의 stomach에 해당
- 증상: 위완창통, 밥맛 없음, 애기, 애역탄산
- 만성간염, 만성담낭염, 위장신경통(스트레스성 위장염), 만성장염, 위하수
- 치법: 소간화위
- 처방: 시호소간탕, 소요산, 평진건비탕(평위산+이진탕+소도지제)

4) 간기승비(간비불화)

- 병인: 간왕비약해서 비의 운화기능이 실조되어 비주승이 안되어 나타남.
한의학의 비는 intestine에 해당
- 증상: 복통 복창 복장명 설사
- 만성간염, 만성담낭염 등등
- 치법: 사간보비
- 처방: 소요산

5) 간기상역(간기상충)

- 병인: 간기울결→일시적으로 간기가 격폭(위로 올라간 것)하고 上逆상역한 것
- 증상: 狂怒광노(미친 듯이 성질 냄), 兩脇下滿痛引少腹양협하만통인소복, 두통, 이릉 등(간실증 + 상부증상 위주), 四肢癱瘓사지계종(경기하는 증상)
- 신경증, 만성간담증질환, 고혈압 등이 해당
- 치법: 소간이기
- 처방: 시령탕

• 간기상역 vs 간화상염

- 간기상역: 일시적으로 상역
- 간화상염: 기울화해서 지속적으로 上炎상염증상이 나타남

6) 간기하역

- 병인: 소설이 태과해 간기가 아래로 내려감
- 증상: 하부증상 위주(협소복창통, 월경부조, 산통)
but 소설기능 실조로 나타나 기본이 기울에 해당하므로
상부증상(조급이노 야매다몽 등)도 존재
- 만성충수염 등이 해당
- 치법: 유간승양 이기지통
- 처방: 대황목단피탕

• 변증시치와 전병전방

: 만성충수염에 대황목단피탕, 담석증에는 소음해독탕 → 전병전방에 해당

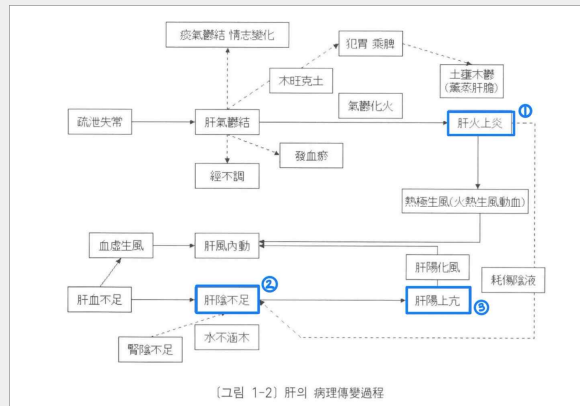
- 간기가 주로 상역하기 때문에 간기하역은 문헌에 거의 X.
- 한체간맥과 변별해야 함(뒤에 다시 나옴)
- : 소복창통이 주증이나 외음기증상이나 외한지냉이 없는 것이 특징

2. 간화상염(간경실화)

- 병인: 간기울결로 기울이 화화하여 **지속적으로 쌓인 것**을 말함.
술 담배 고량미로 열이 쌓여 화화한 것
- 증상: 주로 상부증상(화성이 상행하기 때문)
(: 두통현훈 목적면홍 이롱 조금 구고인건 이명 토혈낙혈객혈)
하부에서는 열 때문에 뇨황 변비 등
- 급성결막염, 담낭염 등
- 치법: 청간사화
- 처방: 용담사간탕, 당귀용회환

• 간화상염이 심해 간음부족이 나타나기도 함

: ①간화상염→화열사가 간음혈을 손상시킴→②간음부족→③간양상향



(그림에서 점선 화살표에 해당)

★ 각각을 비교하여 서술하시오(13, 14, 19)

• 간화상염과 간양상향 비교

간화상염	간양상향
두통현훈 이명이롱 안과질환	
- 극열하고 돌발적	- 병기가 깊
- 병기가 급성, 병상이 심함	- 통증이 은은하고 지속적
- 실열증	- 본허표실증

3. (간)중열증

- 열에 적중되었다(like 중풍: 풍에 적중되었다)
- 병인: 간경이 열사에 소상되어 실열을 유발
- 증상: 천민, 담흑, 눈 아프고 잠 못 자고 잠자다 잘 놀래고 등
- 치법: 소호소사물탕에 초용담 등 가미

4. 간열증

• 간열증=간중열증

- 간열증: 간에서 열증을 일으킨 모든 것
- 간중열증: 열사가 간에 침범한 것
- 병인: 열사가 간을 침범하거나 기울화열한 소치
- 증상: 골증열 신열 소변선황 대변보기 힘들. 열이 심하면 수족건조 안화삽통 등
- 치법: 생간건비탕에 시호를 가미

● 갈랑바레 증후군(Guillian-Barre' syndrome, 급성열성다발성신경염)

여택지 119p. 4번

- 한의학적으로 근위증에 해당
- 熱傷筋열상근(열이 과해 상음→불양근하여 나타남)
- 원인불명이 대부분
- 증상
 - : 60%에서 전구증상으로 상기도 감염(발열 해수 객담)
 - : 하지의 무감각, 지각이상(저린감), 대칭성으로 인대마비
 - : 인대반사는 소실하나 피부반사는 유지됨
 - : 말초성 안면신경마비
 - : 급성으로 발생하여 다른 질환(근무력증)과 감별하기 어려움
- 예후
 - : 예후는 양호한 편이나
 - : 안면마비 등이 후유증이 남음
 - : 가장 문제가 되는 것은 호흡근 마비
- 처방: 虎潛丸호잠환
(陰虛勞證음허노증에 사용, 귀판, 황백, 호골 등 보음하는 약재가 다수 포함 /호골은 CITES)

● **간열과 간화의 비교:** 간화는 정지변화의 내인으로 인한 경우가 대부분

5. 肝癰證간옹증

- 병인: 율분기역으로 혈행이 탁침 → 간경에 응체 → 醞釀化成온양*화성해 발생
*온양: 원래 술을 빚는다는 뜻, 오래 점차적으로 만들어진다는 의미
- 간옹은 서양의학적으로 **간농양**에 해당
: 간농양은 율분이 아니라 세균, 아메바가 원인. 과거 사람들의 인식 부족
- 증상

간저	은은하게 아픈 것. 음증
간옹	통치가 중괴한 것. 양증

- 치법: 소시호탕, 시호청간탕 등

cf. 국시의 정답은 위와 같으나, 실제로는 양방에 보내서 수술하는 것이 확실함.

6. 肝著證간저증(肝着證간착증)

- 병인: 기혈울체하여 간폐가 모두 실하고 담기가 교착하여 발생
→ 간이 어떠한 이유로 종대되어 폐를 압박하여 발생
- 증상: 흉협고만, 불쾌감, 창만, 흉부를 누르면 좋아함, 고통이 없으면 따뜻한 물을 마시고 싶어함
→ 고만: 엽구리와 가슴이 빠근한 듯 불편함
→ 따뜻한 물: 풀어주는 역할 / 차가운 물: 긴장하고 움츠러듦
- 치법: 선복화탕
→ 선복화탕은 풍담으로 나타나는 해수담성에 사용하는 처방.
폐 쪽에서 불편감을 느끼니 사용하는 것

cf. 이와 반대로 폐기종이 있어 팽창되어 간을 압박하는 경우가 있음.
이때는 간이 내려가 복진 시 만져지기도 함.

★ 각각을 비교하여 서술하시오(13, 14)

7. 肝心痛간심통

- 병인: 간경에 열이 있고 수족꺠음맥락에 혈이 응체하여 衝心作痛충심작통
- 증상: 안면색이 파랗고, 한숨을 많이 쉬고 심중에 통증이 심함 (심근경색 유사)
- 치법: 금형자산(금형자=천련자)+현호색
- 천련자는 이기지통하고 성질이 차가움. 유독하므로 장기간 과량 사용 금지
- 현호색은 이기지통하고 성질이 따뜻함. 무독

8. 肝脹證간창증

- 병인: 분노를 억제X → 간이 조달능력을 상실해 발생
- 증상: 험하창만 소복인통
- 기창: 배에 가스가 차서 부글거림
- 수창: 간문맥 폐색, 복막 수분대사 장애로 복수
- 치법: 청간이기. 청간건비탕 등

9. 肝積證간적증(=肥氣비기에 해당)

- 병인: 울혈이 안에 쌓여 장부경락을 막아 적취가 생김
- 증상: 좌협하에 덩어리가 형성됨
- 치법: 비기환을 투여

cf. 적취를 양방의 암세포로 보기도 함

Q. 왜 간의 적취인데 '좌'협하라고 했을까?

A. 과거에는 좌간우폐 좌혈우기라고 함

간의 문제가 있을 때 비장종대(좌측)가 일어날 가능성도 있음

10. 寒滯肝脈한체간맥

- 병인: 외한이 족꺠음간경에 침입해 기혈이 응체하여 발생
- 증상: 소복창통, 고환에 경련성 통증, 고환이 커지고 쳐짐, 음낭냉축, 외한지냉, 여성에서 생리 때 냉통
- 치법: 난간전

● 한체간맥과 간기하역의 비교

- 간기하역: 소급창통, 조급이노가 주증
- 한체간맥: 외음기 증상이 있음. 고환이 커지고 밑으로 쳐지고 음낭냉축~

11. 肝膽濕熱간담습열

- 병인: 비위의 습열이 간담에 溫蒸온증(계속 쌓임)하여 발생
- 증상: 面目周身면목주신, 황달, 발열 구고, 협통, 오심복통, 복창, 腹痛厭食(밥먹기 싫어함)

→ 급만성 간염, 간담도질환 등

- 치법: 청설습열 소간이담 (*청열의 기본 치법: 청열리습)

- 처방: 인진호탕, 생간건비탕(간 실질 병변)

인진호탕	습<열. 열이 더 심할 때 사용	대변으로 습열을 배출
인진사령산	습>열. 습이 더 심할 때 사용	소변으로 습열을 배출

● 습열

: 염증을 의미하는 한의학 용어. 농을 동반하지 않는 일반 장기의 염증
 : 농을 동반하는 염증은 癰瘍. 습열과 구분됨

- 간담습열은 황달, 협부증상, 곤권이 주증이다.

- 간기능검사상 빌리루빈, AST ALT 수치 증가가 나타난다.

: but 간기능검사 상으로 문제인 것의 변증이 반드시 습열에 해당하지는 않음.

한습, 기체, 어혈이기도,,

: "간기능검사 상으로 급만성 간염이라고 진단됨" ==> 말이 이상해!!

→ 기능: 간이 얼마나 일을 하는지 ⇒ 생화학검사

→ 간염: 면역학적으로 항원항체의 유무 ⇒ 면역학검사(항원항체검사)

'간기능 이상=간염'임을 주의

- 환자는 증상을 거의 호소하지 않음

: 간은 침묵의 장기

p.153 간과 관련된 임상 검사 참고(혈액응고검사, 생화학검사)

• L.F.T 일반적인 간기능검사

: 보편적인 간기능검사 항목(병원마다 다르기도 함)

- 1) ALP
- 2) AST, ALT: 간세포 효소
- 3) 감마 GT
- 4) total-B(biliubin), direct-B (indirect 값=total-direct)
- 5) total-P(protein), Alb (글로불린 값=토탈-알부민)

+) A/G ratio: 알부민과 글로불린의 비율

total-P 7.0이고 Alb 4.0이면 A/G ratio는 1.34

• 양황과 음황

양황	선명한 황색, 발열, 맥색, 설태황	습열 증상	실증황달. 습열황달
음황	색이 어둡고 칙칙, 무열, 식소 (소화잘X), 완만, 변당, 맥완	한습 증상	비양부진으로 한습저체 or 습이 열에 편승한 허증 황달. 한습황달

12. 습열순간경하주

- 병인: 간경습열이 간경을 따라 내려가 생식기 주변에서 정체
- 증상

남	음낭습진, 고환종대열통
여	외음부소양, 대하황색종취증

- 자궁경관염 자궁내막증 요도질환
- 치법: 청리간경습열, 용담사간탕

13. 간상증

- 낙상, 타박상으로 간장이 손상됨 => 응급실 보내라
- 옆구리 타박 정도, 늑골에 금이 간 정도면 병원가도 처치X. 그냥 조심해라~

★ 간허증에 대해 아는 대로 써라(06, 08, 09, 11, 13, 18)

제 3절. 허증 공급 저하, 흡수 저하, 배설 증가의 문제로 발생

1. 간혈부족(=혈허)

- 병인: 출혈(배설 증가), 조혈부족(공급저하), 만성병으로 간혈이 손상받음
- 증상: 현훈, 면색무황, 야맹증, 양목건삽, 肌肉瞶動기육순동*, 월경량 감소나 폐경 등 (혈허 증상)

*기육순동: 피곤할 때 눈가가 파르르 떨리는 것. 양방에서는 마그네슘 부족에 해당

→ 저혈압, 신경증, 만성간염 일부, vitamin A 결핍으로 인한 안병 등

- 치법: 보혈
- 처방: 사물탕, 보간탕(사물탕+강활 방풍), 익기보혈탕

• 사물탕 107p. 혈병통치약

- 일절의 혈병, 부인제병에 사용. 보혈의 요약

당귀	생혈화혈	군	생
숙지황	보혈	신	장
작약	양혈영음	좌	수
천궁	행혈	사	장

- <동의보감> 춘기에는 천궁, 장혈하기에는 방풍을 가미한다.
- <보종익기탕춘방> 천궁 방풍 소엽 형개 가미. 알려지성 비염에 효과적.

• 당귀의 효능: 1) 보혈 2) 윤장

- 제천전, 윤혈음(노인, 허약자의 변비에 사용하는 약)에서 당귀의 역할은 윤장
- 당귀를 허증변비에 사용. 역으로, 대변을 무르게 보는 환자에게 당귀를 사용하면 악화될 것

- 팔물탕

- 사물탕+사군자탕=팔물탕. 기혈양허를 다스림.

- 십전대보탕

- 팔물탕+황기육계=십전대보탕.

- 밥짓기로 비유해서 이해: 술=몸/물=사물탕/쌀=사군자탕/불=육계/뚜껑=황기

2. 간음부족(=음허)

- 병인: 간혈부족 또는 신음부족 (간신동원)
- 증상: 간혈부족증. 관홍, 도한, 심번부족 (=갱년기 증상들)
- 치법: 자음양간
- 처방: 기국지황환, 일관전(사삼 맥문동 당귀 구기자 천련자), 생간건비탕(간실질 병변)
- 간음이 부족해 음허내열하므로 관홍, 도한, 심번불면과 같은 갱년기 증상이 나타나고, 상대적으로 간양이 요동해 더 열감을 느끼게 된다.
- 임상에서는 간음부족증이 가볍게 나타나고, 양향어상증이 주로 나타난다
 - 1) 환자가 양증을 많이 느끼기 때문
 - 2) 양증이 겉으로 표가 많이 나기 때문
 - 3) 양증이 상부에서 많이 나타나기 때문

3. 간양상향(음허양향)

- 본허표실증 again 실증처럼 들리나, 베이스는 허증!
- 병인: 간음부족으로 간양이 偏亢편향
- 증상: 상부증상 위주. 두창통, 현훈, 면홍목적, 이노, 정신여착, 이명 등
설홍태소흑무 맥현흑세
- 고혈압, 안질환일부, 신경증
- 치법: 자음 평간 잠양. 천마구등음

- 간양상향이 주로 나타나고 간음부족이 잘 안보일 수 있음(양증이 잘 보이니까)
- 간음부족이 위주로 간양상향이 가벼운 경우, 간음부족증과 간양상향증이 동시에 모두 현저하게 나타나기도 함

- 간양의 승동이 끊임없이 일어나면 정신흥분으로 실면, 이노한다.

: 밤새 고스톱을 쳐 몸이 피곤한데, 돈까지 잃어 정신흥분 상태가 되어 잠을 잘 못 자고 화가 난다고 이해하면 됨.

: 숙면을 위해서는 몸을 혹사시키는 것보다, 잔잔한 상태 유지하는 것이 good

★ 각각을 비교하여 서술하시오(13, 14, 19)

- 간화상염과 간양상향의 비교

간화상염	간양상향
상부증상(두통, 현훈, 이명, 이롱, 목질환)	
- 두통이 돌발적이고 귀와 눈 질환 급격히 발생 - 설홍태황 맥현삭 - 병기 짧고 돌발적	- 두통이 끊임없고 귀와 눈 질환 서서히 발생 - 설홍태소흑무 맥현흑세 - 병기 길고 완만 - 중년기 이후에 나타남

4. 혈조생풍(혈허생풍)

- 병인: 음휴혈조하여 생풍
- 증상: 피부증상이 많이 나타나는 것을 혈조생풍. 피부건조, 소양탈설*, 모발이 탈락, 손톱 갈라짐

*탈설: 가루가 떨어진다. 비듬, 피부가 하얗게 일어나는 것

→ 적응증: 건조 아토피, 상피증

- 치법: 양혈윤조거풍
- 처방: 양혈거풍탕, 임상에서는 생혈윤보음

5. 간기부족(=만성피로)

- 병인: 간의 승발기능 부족 또는 근맥 실양
- 증상: 억울, 선공, 권태핍력, 관절불리 등 피로 관련 증상
- 치법: 익기양간. 익기보혈탕

6. 간양부족(간허한증)

- 병인: 간양이 부족해 심, 비를 助養조양하지 못함
- 증상

허증	양위 월객색담양소
한증	외한지냉, 소복냉은통, 근맥구급, 음낭냉습

- 치법: 난간온양탕

*난간: 실증의 한체간맥에서 난간전을 사용. 그러나 허한증에는 난간온양탕!

★ 각각을 비교하여 서술하시오(13, 14)

• 간양부족과 한체간맥의 비교

간양부족	허증. 내상, 오래된 병에 의함. 병세와 증상이 완만	허증+한상
한체간맥	실증. 갑자기 침입한 외한사. 병세가 급하고 증상이 심	외음부 증상, 통증

7. 간기증

- 원인: 사려과다, 노력과도, 부인의 생육과다, 실혈과다로 간혈부족
- 증상: 흥격비민구토, 복중공우, 복명 등 (과민성대장증후군 증상)
- 신경증 일부, 위신경증
- 처방: 사물탕+좌궁환(간화로 인한 구토에 사용). 생화탕(출산 후 아침통)

*간기울결과 비슷하나 간기증은 원인이 혈부족, 혹은 사려과다 등(=>스트레스로 인한 허증이라 생각)

8. 간허한증

- 병인: 간허로 영혈이 내수하지 못해 다한증이 생김
- 증상: 조금만 움직여도 땀이 난다(자한의 증상)
- 치법: 당귀육황탕(도한 처방) + 백작약 오매 오수유

증상과 치법이 일치하지 않는데?!

• 自汗과 盜汗 비교

- 자한: 기허. 활동 시 흘리는 땀. 황기건중탕, 보중익기탕, 옥경풍산
- 도한: 음허. 수면 중 흘리는 땀. 당귀육황탕
- ⇒ 기허자한 음허도한에 너무 매몰될 필요가 없다.
- 자한이어도 음허에 의한 경우가 있다.

9. 간허열증

- 병인: 혈액이 휴손되어 간을 호양하지 못함
- 증상: 다노다롱 두통현모 이명, 열이 기육지하 골절상부(열이 蒸), 인묘시(오전 3시~7시)에 심하다
- 치법: 사물탕+소시호탕

10. 간노증 5번 간기부족과 유사. 만성피로라 생각하면 됨

- 원인: 전신적 스트레스로 혈부족이 간기 혈 공급이 부족해짐
- 증상: 눈이 침침, 눈물이 많이 나오고, 겁이 많아져 혼자 잠을 자지 못함*

*공외 불능독와: 심담허해서 나타남. 인숙산, 가미용담탕 처방

간허한	구고, 번민, 筋攣骨疼근련골동
간실열	면흑목적. 실열이 있으면 음허를 발생시켜 음허가 오래되면 면흑한 증상이 나타날 수 있다. 정신항흥, 모체색요, 관격*불통

*관격: 관: 소변불통, 격: 구토

- 처방: 귀용원(녹용+당귀)

+) 실열→음허→면흑목적: 면흑목적은 음허가 있다는 말이므로 영양각산도 사용 가능

11. 간손증

- 원인: 노손과도, 정신과도로 혈기가 모손되어 간음 보양X
- 증상: 헝통시발(허증이므로 헝통이 가끔 나타남), 근골구련, 관격불통증
- 처방: 사물탕, 보간환

12. 간수증(복수)

- 원인: 간혈이 고갈되어 조혈 장혈 해독 소설작용이X, 복부에 축수하여 나타남
- 증상: 복부팽만, 돌아눕기 어렵고, 복통, 소변이 잘 안나옴(소변저류 때문)
- 치법: 청간 건비 이수
- 처방: 생간건비탕

*창만증에서 다시 언급할 것

13. 간비증

- 병인: 간기가 기행불리하고 한습이 적취하여 나타남
- 증상: 아와즉경 근맥연축 요복통 다식(출식이라 되어있는데 잘못된 것) 다음 다소변(소갈증과 유사)
- 치법: 삼비탕

*임상에서는 삼기음을 다용. 허한 틈을 타 풍한습 삼기가 들어와 생긴 비증에 사용

14. 담결증

- 원인: 음허화왕해서 간사가 內熾내치해서 간경을 옹색하여 나타남
- 증상: 수족결냉, 현훈, 구토, 인사불성, 전간
- ➔ 간성혼수, 간성뇌증에 해당
- 치법: 안신제풍 소간해울
- 처방: 생간건비탕

• 결증: 간성뇌병증, 간성혼수 hepatic coma

: 간경화, 간암 등 간장질환이 오래되거나 전격성간염(급성간염)으로 간에서 단백질 대사의 장애가 나타난다. 단백질의 최종산물인 암모니아가 재합성되거나 요소로 배출되지 못해 독소로 작용한다. 암모니아가 BBB를 통과해 뇌로 가서 중추신경 뇌 손상을 주어 결증이 나타난다.

: 암모니아를 떨어뜨리는 가장 쉬운 방법은 설사, 관장시키기 혹은 단백질 제한 식이.

: 초기에 정신혼란이 없다가 방심한 사이 정신 혼란(지남력 장애), 신경 근육 장애, 의식 장애가 나타남. 정신이상은 강직, 신전 발작 등이 혼합되어 나타나기도. 혼수가 나타날 때 복수 부종 지주상혈관종(거미상혈관종, 성상혈관종), 수장홍반(손 두툼한 곳이 빨개지고 오목한 가운데는 X), 비장종대가 있다.

15. 간증

- 병인: 열병이 나은 후 방노손상해 진액이 말라 열이 나타남
- 증상: 열이 기육지하 골절지상부에 있음(蒸)
- 처방:시호음자

16. 간절증(=죽을 때가 되었다)

- 병인: 족결음지맥이 쇠해 근을 영양하지 못함
- 증상: 입술이 퍼렇고, 손발에 축축하게 땀이 난다(=사지가 熱習칩습*)

*칩습: 한출, 전두. 땀나면서 땀다

제 4절. 간풍내동

1. 간양화풍

- 본허표실증
- 병인: 간음부족이 base, 간양이 상대적으로 상항하여 나타남
- 증상: 두통현훈 감각이상 떨림 조음장애(언어장애) 보행장애 안면마비 혼수 실어증 등
- 특징: 근맥불리, 편측마비(CVA에 해당)
- 치법: 치법: 평간식품
- 처방: 진간식품탕, 천마구등음
- 갱년기 이후 음허양항한 경우가 많. 병기가 비교적 만성이다, 길다는 뜻

2. 열극생풍

- 병인: 고열이 간풍을 동하게 함
- 증상: 열증, 상부증상. 고열, 갈증, 섬어, 눈을 위로 치켜뜬(양목상변), 팔다리 뒤틀리고 심하면 의식장애. 각궁반장 등
- 특징: 체간성 운동장애(角弓反張각궁반장, 四肢拘急사지구급)
- 치법: 청열식품양간
- 처방: 영양구등탕
- 고열로 인한 혼미를 동반하는 질환, 뇌막염, 파상풍 등 열성 발작에서 나타남
- 병기가 짧은 실증
- 연령에 관계없이 나타남

3. 혈허생풍

- 병인: 허증, 실혈, 오래된 병으로 肝血虧虛간혈휴허하여 나타남
- 증상: 혈허증상, 피부증상. 출혈, 만성질환으로 현훈, 안색창백, 시야혼탁, 감각이상, 기육체동(마그네슘부족)
- 특징: 양측 장애
- 치법: 양혈식품
- 처방: 사물탕 보간탕 + 조구등 백강잠 영양각 등 식간풍 약재 가미
- 흔히 쇼크에서 다뤄지는 원인 증상.
- 대개 여성에게 많다.

제 5절. 간병의 치법과 상용약물

다 못하겠죠? 5번 식간풍약, 6번 잠간양약 정도만 알아두세요.

과거 국시에는 이런거 다 나왔는데 요즘엔 이런거 안낸다

5) 식간풍	조구등 석결명 영양각 강잠 전갈 오공 방풍 강활 천마 천남성
6) 잠간양	진주모 용골 모려분 자석 대자석

• <금궤요략> 未病

- 건강과 질병의 사이
- 미병 상태를 잡아내 치료하는 것도 중요하다 → 예방한의학.

★ 간병의 섭생에 대하여 서술하시오(10, 12, 14)

제 6절. 간병의 섭생

1. 춘계양생

- 봄철에 몸을 잘 추슬러라. 봄철 음식 위주로 먹어라. 의복도 봄에 맞게 입어라
- 자연에 순응하는 양생법을 강조

1) 정신을 다스려라

: 노, 성질내는 것을 주의

2) 일상생활을 규칙적으로

: <소문 사기조신대론> 봄, 여름에 야와조기. 늦게 자고 일찍 일어나라
(겨울에는 조와만기 일찍 자고 늦게 일어나라)

⇒ 계절에 맞게 생활하라

3) 養陽斂陰양양영음

: 겨울-음, 여름-양. 그 중간인 봄이니 추위도 잘 막고 오는 더위도 잘 방어해라

4) 飮食調養음식조양

: 제철음식 먹어라

5) 적당한 운동하기

2. 精神調攝정신조섭

- 마음 상태가 우울하거나 정서가 저조하면 면역기능이 떨어지고 각종 질병에 이환될 수 있다.

+) 약석의 효능에만 의지할 것이 아니다!

3. 節慾保精절욕보정

- 성생활의 절도가 없으면 신정이 모손되고, 간장까지 손상된다(간신동원)
- 간은 종근을 주하고, 양위, 유정 등은 간병과 관련이 있다.
- <수세보원> “대치입방을 하면 남자는 정액쇠소, 양위불거하고 여자는 악혈이 흐르고 악창이 생긴다” = 성병과 관련된 이야기

4. 勞逸適度노일과도

- 과로가 축적되지 않게 해야 한다. 적절한 휴식과 안정이 필요하다
- BUT! 걸으면 살고 누우면 죽는다 => 적절한 운동이 좋다.
- 간병 환자는 급성간염의 발병기나 심한 간기능장애로 절대 안정을 요하는 경우를 제외하고는 적당한 운동이나 활동을 하는 것이 좋다. 개인차가 있음 고려
- : AST ALT 40 이하가 정상인데, 정상 수치임에도 피곤함을 느끼기도 함. 수치가 200 이상이면 절대 안정을 취할 것 권고

5. 食養注意식양주의

- 간질환이 있는 경우 균형있는 식이를 원칙(간뿐만 아니라 모든 질병에서도 마찬가지)
- 고칼로리 고단백 권장하나 case by case

복수 차 있으면 -> 저염식, 혹은 무염식 권장

복수 차 있고, 알부민 수치 떨어짐 -> 고단백식 권장

암모니아 수치가 높으면 -> 관장, 사하제, 단백질 제한

제 3장. 황달론

제 1절. 개요

1. 황달

- 목황 신황 소변황적 등 피부 점막이 황색으로 착색되는 것
- : 체모, 치아, 손발톱은 노랗게 변하지 않음(혈액이 가는 곳이 노랗게 되는 것)
- 노랗게 되는 이유는? **혈중 빌리루빈이 상승**되어 있기 때문
- 고대에는 黃癰瘡단 또는 癰熱단열이라고도 함
- : 단은 습열병에 전신이 황색, 흑색으로 되는 것

1) 한대 장중경 <상한원후론>	황달의 지속기간, 구갈의 유무에 따른 예후 설명
2) 수대 소원방 <제병원후론>	황달이 발병하는 정황에 따라 출현하는 증상에 의거해 28후(候)로 구분
3) 당송대 손사막 <천금방>	황달을 5종으로 요약하여 오달이라 함 *교재는 손사막의 오달을 소개
4) 왕부는 육달삼황, 동사량은 육달 삼십구황	
5) 금원대 주단계	병인병기를 습열중심으로 설명하고, 치료에 있어 리소변 을 우선으로 삼음
6) 원대 마천익	음황 양황으로 구별
7) 명대 이천	습황과 건황으로 요약 (습황은 마천익의 음황과 유사 개념, 건황은 양황과 유사)
8) 청대 장경악	음황, 양황, 표사발황, 담황으로 분류, 담즙이 外溢외일 하여 不備常道불순상도함을 지적
9) 오우가, 침금오는 황달의 전염성을 밝힘	
10) 우리나라 <향약집성방>	26종 황달 분류

50p. 금궤요약 황달의 예후

황달은 18일 안에 호전이 되어야 된다.

10일이 지났는데 좋아지지 않으면 난치에 속한다.

50p 황달의 전염성

<잡병원류서촉>에서 천행원려=전염성이 있다고 함

종합하면

정의	- 황달은 빌리루빈이 증가되어 공막, 피부 점막이 황색으로 착색되는 것 - 혈청총담즙색소가 2mg/dl 이상인 상태(1.2~1.4가 정상) *인종의 피부색에 따라 황색이 잘 안 보일 수 있으므로, 공막에서 나타나는 것이 기준 *공막에서 3.0mg/dl 이상부터 노란색이 나타남
병인병기	습열
증상	- 목황 신황 소변황이 주요증상 - 동시에 전염성이 있음
불현성 황달	- 1.4~3.0 사이 - 정상치를 벗어났으나 황달 증상이 아직 나타나지 않은 것

제 2절. 병인병리

- 외인: 시사외습
- 내인: 음식부절 비위허한 내상부족

1) 時邪外襲시사외습

(1) 습열 혹 역독사기의 외습

- 비위가 서습, 습열, 역독에 감수해 습열이 나타나고, 담즙이 넘쳐흘러 바깥으로 피부에 스며들고(신황) 위로 안구를 염색하며(목황) 아래로 방광에 흘러 들어가 소변황이 나타난다.
- 역독의 사기가 검발하면 발병이 급속하고 전염성이 있다 → A, E형 간염에 해당

- 간염에는 A, B, C, D, E, G형이 있다.
- A형, E형: 물이나 분변에 의해 감염되어 급성적으로 발생, 만성화되지 않음
- B형, C형: 폭발적으로 발생하지 않음. 감염원이 혈액, 접촉에 의하기 때문.
- 심한 경우 출혈, 신혼(hepatic coma) 등의 증상이 나타남: 급황 혹은 온황

(2) 寒濕入侵한습입침

- 양허한 환자가 외감한습이나 습사에 노출되어 발생
- 인진사역탕을 활용한다고 했으나, 사역탕의 부자가 간독성을 유발할 수 있으므로 절대 사용하지 X

2) 음식부절 (습열황달과 유사)

- 음식부절, 기포실상(불규칙한 식사), 과음, 고량후미
- 주식과도로 비위에 습이 생기고, 간담을 횡역해 황달이 발생한다.
- 비위를 손상 → 비실건운 → 습탁이 만들어짐 → 간담에서 황달

3) 비위허한 (한습황달과 유사)

- 본래 비위가 허약하거나 과로해 비양이 허손되어 한습이 중초에 저체되어 황달이 발생
- 여기서 한습은 비양부진하여 나타나는 내인(*시사외습에서는 외인으로서 한습)

4) 積聚轉化적취전화

- 적취가 오래되어 사라지지 않고 어혈이 담도를 조체하여 답습이 넘쳐나 황달
- <장씨의통> “어혈발황은 반드시 대변이 흑색이며...”
- : 어혈발황 = 흑달
- : 대변이 흑색 = 소화기에 출혈O, 간의 지혈인자가 부족

요약하면

- 1) 비위에서 발병해 간담을 침범
 - 2) 외사가 직접 간담을 침범
- 따라서 황달에 간담비위를 모두 고려해서 봐야 함

제 3절. 증치

★ 오달을 요약하라(12, 18)

1. 五疸오달 손사막의 천금방 5종 황달

1) 황달

- 증상: 무릎 소변, 면목, 치아, 지체가 금색과 같음. 안와하기를 좋아하고 활동하기 싫어함. 위중에 열이 있으면 식후에도 배고파한다**. + 구취

*치아는 변하지 않음. 황달 생기면 피곤, 눕기를 좋아하니까 치아관리 문제로 변했을 것임

**위중의 열을 소각장으로 이해, 계속 태워 없애니 배고픔을 느낌

- 치법: 황달에 인진오령산, 인진호탕

인진오령산	실제로는 육계를 뺀 인진사령산을 활용. 습을 주로 소변으로 뺌
인진호탕	열을 많이 뺌. 대변으로 배출
가감위령탕	가장 많이 사용하는 처방

2) 주달

- 술로 생긴 황달. 영양장애가 동반됨(과거엔 안주를 잘 못 챙겨먹어서)
- 증상: 소변이 잘 나오지 않음. 가슴이 답답하고 울렁거리며 괴로움, 열감, 토하러 하고, 음식을 먹지 못하고 발바닥이 뜨거움(과한 음주 혹은 음허가 원인)
- 치법: 갈출탕* / 대금음자, 갈화해성탕 사용 가능

*같은 갈근을 의미하는데, 갈화가 더 좋음. 대신 갈화는 비린 맛이 있으니 환자에게 미리 안내할 것

3) 穀疸곡달

- 음식으로 생긴 황달
- 증상: 한열이 있고*, 음식을 먹지 못하고 먹으면 어지럽고**, 발한하고 복부창만, 오래되면 발황한다. 위중에 열이 있거나 대기 후에 과식하여 정체되는 데 기인한다

*식적류상한: 소화기능이 약한 사람이 음식을 먹고 체하면 감기증상처럼 나타남

**식후 두통과 어지럼증: 소화가 안되면 흔히 나타나는 증상. 반하백출천마탕

- 치법: 소온중탕, 소달건비탕, 인진치자탕(인진+치자+지실)

4) 女勞疸여로달(= 색달)

- 황달전구기에 과도한 성생활, 성접촉하여 바이러스 감염으로 나타나는 것
- 증상: 이마위가 검어지고 땀이 약간 나며 저녁에 손발바닥에 열이 나고 방광이 급하여 소변이 자리한다 (= 음허노증)
- 치법: 석고산, 진교음자

5) 黃汗황한(=노란 땀)

- 증상: 몸이 붓고 발열이 있으며 황색의 땀이 있어 의복을 황색으로 물들임. 외감증상

*땀이 황색인가?

: ㄴㄴ 이건 황달이 아니라 허손병에 해당.

: 자한과 도한이 아주 심할 때. 간담도 질환이 XX

+) 오달의 맥상이 洪數한 것은 實熱이며, 微溫한 것은 虛證이고, 援大한 것은 順證이며. 弦急하며 緊한 것은 逆證이다. ← 이런거 안나올거에용

+) 溫疸온달

- 오종황달 외에 역려발황, 즉 유행성 감염증에서도 나타나는 것
- 급히 치료하지 않아 진행된다면 전격성간염이 됨

2. 양황, 음황 원나라 나천익 분류 기준

- 양황과 음황으로 분류되는데, 둘이 서로 전변되어 바뀔 수 있다.
- : 치료시기를 놓쳐 비양부진하면 양황이 음황이 될 수 있고
- : 음황은 습열이 안에서 증하면 양황이 될 수 있다.

1) 양황

습열황달	1) 열이 습보다 중한 경우 - 황달의 색이 선명함 - 열증+소화기증상: 발열구갈 대변비결 소변색황적 오심구토 복부창만 - 치법: 청열리습 사화이독/인진호탕(대변으로 배출)
	2) 습이 열보다 중한 경우 - 황색이 선명하지 않음 - 증상: 두중신곤(무겁고 피곤함), 흉완비만 설태후니미황 맥유완 - 치법: 리습화탁/인진오령산(소변으로 배출) - 습열황달은 전형적 바이러스성 급성 간염에 가까움 - 예후 좋고 만성화되는 비율 감소시키기 가능함
열독황달 (급황)	- 습열황달보다 발병이 급속하고 돌연히 출현, 병기가 짧고 신속히 악화됨 - 증상: 고열번갈 흥복참만 신훈섬어 육혈 변혈 기부자반(출혈 증상) - 치료: 청열해독 양혈자음/인진호탕+서각지황탕, 황련해독탕, 시호청간탕 - 역려성발황 일부가 여기에 속함, 온황이라고도 함. - 전격성 간염 등이 해당하고 예후가 극히 불량

- 양황에는 대체로 간세포성황달 중 황달기가 짧은(장중경 18일 위기설)형, 즉 바이러스성 급성간염, 전격성 간염이나 만성간염 과정 중 일어나는 급성형 등이 이에 속한다.
- AST, ALT, alk-phosphatase, GGT 등의 현저한 상승과 연관지어 생각

2) 음황

한습황달	- 한증+소화기증상: 식소, 완민, 복창, 대변부실 - 치법: 건비화위 온화한습 - 처방: 인진오령산+가감위령탕 건강 오수유 자감초 가 *한으로 나타난 황달에 인진사역탕 사용 XXX
어혈황달	- 더 안 좋은 상태, 오래 병이 낫지 않고 비신화어해서 나타남 - 증상: 황색이 어둡고 심하면 얼굴이 까맣고(흑달), 복부 창만 하여(복수) 덩어리가 있는 경우 있고(적취가 만져짐), 흉합자통 기부갑작 형체팽수(어혈증상) 정맥이 융기*, 흑색변(출혈) *간질환에서 정맥융기는 2가지: 여기서는 caput medusa(메두사머리)에 해당 - 치법: 활혈와허 건비익신 - 처방: 청간건비탕 단삼 목단피 포황 당귀 천궁 도인 등 파어, 화어지제 가

★ 양황, 허황, 편황, 음황에 대해 써라(10, 11, 14, 15) / 음황에 대해 써라(08) / 허황, 위황, 위황에 대해 써라(06, 10, 15, 19) / 허황과 위황에 대해 써라(11)

3) 허약황달(허황)

- 황달에 해당하는 것과 아닌 것이 있음

허황	<금궤요략> 복만신위황 조부득수 속황가 - 용혈성 황달, 간경변 - 기혈허 증상: 비위허약 기혈부족해 나타남 - 치법: 보신건비 온중 익기보혈 - 처방: 귀비탕 삼출건비탕 등
僞黃 위황	<증치요결>에서 역유편신황자 단황불급이목 - 복막과 피부가 노랑지 않다 : 빌리루빈과 관련X, 누렇게 뜬 상태 - 복막발황이 없어 황달에 속하지 않는다

4) 萎黃위황

- 황달이 아니라 빈혈에 해당(누렇게 뜬 상태)
- 공막과 점막은 발황하지 않음

비허적체	- 증상: 얼굴이 누렇게 되고 부음, 식사를 잘 못함, 식후 복창하고 생미 다엽지기를 기식*한다(생쌀, 차 이파리 등) - 치법: 건비소적, 평진건비탕 - 총적을 겸한 것이 확실하면 구충제 사용(파적산 말고)
기혈양휴	- 증상: 피부가 위황하고 권태핍력(기혈허증), 현훈이명 심계소수 대변 - 치법: 귀비탕 인삼양영탕 등 - 혈중빌리루빈의 상승X

*pica(이식증, 이미증, 식욕도착증/소아과의 소아간증과 유사)

- 철결핍성빈혈의 특이증상 중 하나

: geophagia 흙을 떠먹음

: amilophagia 밀가루를 퍼먹음

: pagophagia 얼음을 먹음

+) 僞黃위황: 색소침착에 해당, 카로틴(굴, 당근, 수박) 과다 섭취 시 발생.

제 4절. 예후

1. 황달의 지속시간에 따른 경과

★ 장중경 십팔일위기설을 황달질환과 연결지어 설명해라(10, 11재시, 12, 13, 14)

- 중경에 의하면 18일 이내에 치료되어야 하고, 아니면 난치

50p <金匱要略> 黃疸之病 當以十八日爲期 治之十日以上瘥 後劇爲難治

황달지병 당이십팔일위기 치지십일이상채 후극위난치

: 황달이 3주 내 회복되면 예후가 좋은 것이고,

20일이 지났는데 황달이 심해지면 예후가 좋지 않다.

1) 신생아 황달: 대개 2주 이내에 해결

2) 급성 바이러스성 간염: 황달이 1주에 최고조, 점차 감소. 길어봐야 6-8주

3) 약물로 유발된 황달(약인성 간손상): 약물 중단하면 2-3주* 내에 소실됨. 황달이 너무 지속되면 담즙성 간경변을 일으킬 수 있다.

*2-3주 아님. 2학기 내용인데 약인성 간손상 나타난 것이 의심되면 RUCAM scale로 확인

4) 전격성간염: 황달의 발생이 급박하고 매우 짙어지며 2주 이후에 사망할 수 O

5) 간암 담도암 췌장암: 원인인자를 제거하지 않는 한 황달이 지속적이며 악화됨, 간담도의 폐색을 일으켜 발생.

- 따라서, 18일 위기라는 것은 예후가 양호한 질환에서 유발되는 황달이 대개 10일 전후로 점차 호전이 되고, 오히려 악화되는 것은 예후가 불량한 것이다.

- 대량괴사가 유발되는 경우는 황달이 짙어지고 특이한 악취(간성 구취, 재래식 화장실 냄새 암모니아 때문에), 정신혼미(간성 혼수)가 나타날 수 있다. 전해질 이상, 발열을 동반한 오한 등이 있으면 예후가 불량하다.

- RUCAM scale의 한가지 항목인 de-challenge

: 만약 십전대보탕으로 인한 약인성 간손상이 의심된다면?

→ 십전대보탕 복용을 멈추고 8일 뒤(실제로는 일주일-열흘 후) 재검사

: AST ALT가 200 이하로 떨어지면 +2점 이렇게 점수를 부여

→ 여러 항목의 점수를 종합해 전체 합이 5점 이상이면

: 그 약물로 인한 간손상의 가능성이 있다고 평가

- 약인성 간손상

: 한약은 안전하다? L L한약도 독이 있다. 독을 어떻게 사용하느냐에 따라 치료효과 혹은 독작용이 나타나는 것. 한약이 양약보다 상대적으로 덜 일으킨다는 것!

263p. 신생아황달

- 정상유아에서 황달은 생후 2~5일에 최대에 달하고 2주 내에 없어지는 것이 흔하다.
→ 18일 위기에 해당, 예후가 양호

- 원인: 여분의 적혈구의 용혈, 간 빌리루빈 포화를 일으키는 효소의 상대적 결핍, 장관에서 빌리루빈 흡수의 증가

- 태아가 뱃속에 있을 때에는 모체에서 빌리루빈 대사를 해결했는데, 출생 후 스스로 빌리루빈을 해결하기 전까지의 기간에 황달이 나타나는 것. 생리적 이유.

- 황달 수치가 너무 심하거나 2주가 다 되었는데 사라지지 않으면 인큐베이터에서 450nm 파장을 갖는 광선치료

: 혈중 간접빌리루빈(비포합형)이 직접빌리루빈(포합형)으로 바뀌어 빠져나가게 됨.

2. 황달 색과 관련된 예후

- 칙칙한 색, 안목직시(doll's eye movement)*, 두경을 동요하는 것

*고개를 돌리면 눈이 바로 따라와야하는데, 신경이상으로 눈이 천천히 방향이 바뀜.
hepatic coma와 연관

- 구순 주위와 변흑하면서 유한이 배출되는 것

- 사지에서 땀이 난다

⇒ 간절증. 심기가 단절된 것으로 난치에 속한다.

- 비와 신이 병들면 흑달이 되고 신황하며 안색이 흑색으로 변한다.

: 만성적 간장질환이나 황달이 오래되면 빌리버딘이 상일하고 멜라닌 색소가 침착되어 흑갈색의 피부, 안면색이 더욱 어두워짐

3. 식생활과 습관에 따른 예후 PASS

4. 황달과 동반되어 나타나는 증상에 따른 예후

- 증상이 적을수록 예후가 좋다

1) 창만촉수

- 간 비 신이 관여. ★ 창만의 3장은 간 (비) (신)의 삼장이다 (18)

- 문맥압항진에 따라 복수가 차고 위장관출혈(식도정맥류)이 나타남.

- 감염(자발성복막염이 잘 발생), 신장기능 장애(간질환이 오래되어 복수차거나 해서 이뇨제를 많이 사용하면 간신증후군*)

*오랜기간 간질환을 앓아 신장의 기질적 이상은 없으나 신장기능이 떨어지는 것.

2) 일포시 반오한 (오후 3-5시 경에만 열이 남)

- 발열이 있다. (발열 = 감염 의미)

- 간경변증에서 복수 동반 환자가 지속적으로 발열이 있으면 원발성 복막염임

: 세균감염의 증거는 없으나 자발적으로 복막염이 나타남. 몸 안에 유해균 때문

3) 소변불리 대변흑색

- 황달에서는 대소변이 가장 중요

: 습열의 치료 대법은 通利二便통리이변. 인진사령산(소변), 인진호탕(대변)

- 만성간질환이 간경변으로 진행함에 따라 문맥압 항진, 비 기능항진으로(여기서 비는 spleen) 혈소판이 감소한다.

- 소화성궤양, 지방변 등이 발생하고 예후가 불량

- 대변을 아예 못보는 것도 예후가 불량함

- 비장의 파혈작용

: 비장은 surveillance cell이라는 감시하는 세포가 수명이 다한 적혈구, 형태 이상 적혈구를 탐식하는 작용을 하고, 파혈작용을 수행한다.

- 범혈구 감소: 간문맥이 항진하게 되면 비기능이 항진됨

- 간은 double supply로, 동맥, 문맥을 통해 간으로 혈액이 들어옴

→ 그런데 어떤 이유로 문맥압이 항진

→ 그럼 비장에서 빠져나가야 할 혈액이 빠져나가지 못하고 역류

→ 비장 커짐 → 그 결과 범혈구 감소

(혈소판 뿐만 아니라, 백혈구, 적혈구 모두 포식)

4)搖頭요두 直視직시 柔汗유한

- 요두와 유한은 앞서 말한 칙습에 해당

- 직시는 doll's eye movement

- 전격성간염에서는 황달색이 점점 짙어지고, 간성구취(암모니아 냄새), 간성혼수로 지남력 장애, doll's eye movement, 의식장애, 강직성 경련 혼미를 동반하게 된다.

제 4장. 협통론

제 1절. 개요

脇협	측협부 액하에서 제12늑골까지의 부위를 총칭, 肉과 骨을 합하여 말함
肋늑	골 부위만 가리킴
肘거	열 거/원래 열려있다는 뜻으로, 겨드랑이 뒤 손이 닿는 부위 협의 近背近腋근배근액 부위
季肋계륵	협의 아래부위, 측협의 11-12늑연골 부위
眇묘	허구리 묘/늑골하 연육. 12늑연골 하방, 장골능의 윗부분 <소문> 계륵의 아래, 척추 양방향의 비어있는 부드러운 부분

: 협통은 거통 늑통 거통 계륵통 묘통을 포괄함

장중경	- 협통: 외감협통 + 잡병협통 - 외감협통 : 풍한지사가 화열하여 한과 열이 합해져 傳入少陽전입소양하기 때문에 발생. 소양경증을 같이 일으키는 경우가 많음 - 잡병협통: 담음, 식적 등으로 비롯 - 소시호탕, 십조탕 *십조탕은 독한 약재(원화, 감수, 대극, 감초)로 구성되어 잘 사용 X
손사막	간실열, 담실열, 비열, 신실열 등으로 나눔
주단계	<단계심법> 협통을 3가지로 나눔 : 脇痛有肝火盛 간화성해서 목기가 실함 : 有死血 有痰流注 어혈, 담유주.
허준	<동의보감> 5종협통 분류. *우리 교과서도 5종

- 임상에서 협통은 간담도 질환, 췌장염, 늑간신경통 등에 해당
- 신장, 대상포진 등도 고려할 것

제 2절. 병인병리

- 대부분 실증. 오종협통은 다 실증임(사실 6종협통인데 건협통만 허증임)

기울	- 대노기역 정지울결로 소설불리하여 발생 (소설기능 문제→실증) - 양협하통, 인소복(: 간실증 증상)
어혈	- 기행하면 혈행하고 기체하면 혈체한다. - 기혈운행에 영향이 미쳐 어혈되어 협통 유발 - 특징: 오후에 발열이 난다. 일점통, 한 군데만 아프다.
풍한외감	- 풍한이 화열해서 간담을 침범하거나 습열로 인해 협통이 발생
식적	- 비위허약하거나 고량후미 생랭지물을 과식해 소화가 안 되어 적취를 형성 - 주로 우측에 생김*
담음	- 비의 기능장애로 수습이 불화하여 습담이 저색하게 됨 - 수음이 협간에 있어 漉漉有聲록록유성**하며 咳嗽引痛해수인통 - 懸飲현음, 또는 流飲유음이라 함
허로	- 성생활 과도, 질병을 오래 앓아 몸이 허약 - 통증이 은은히 아프다(허증이기 때문)

*복진에서 우측은 주로 식적, 좌측은 어혈, 가운데는 담음으로 많이 나타남.

→ 복진 검사를 했는데 특별한 것이 나타나지 않으면 이걸 응용하기도 함

**뱃속에서 소리나는 것은 크게 2가지

- 1) 물이 차서 생기는 것: 록록유성(배에서 꾸룩꾸룩 물소리가 남).
궁하탕(방약합편 중통 100), 십조탕 사용
- 2) 가스가 많이 차서 나타남: 배를 만지면 동동소리가 남.
배기음(청감의감)

제 3절. 증치

: 불통즉통 통즉불통이므로, 기혈소통을 위주로 함.

1. 오중협통(사실 6개)

1) 기울협통

- 병인: 대노해 기가 역상하거나 모려를 발생하지 못해(소설기능이 X) 발생
- 특징: 통처가 일정하지 않다. 감정변화에 따라 통증의 증감이 나타난다.
- 증상: 소화기 증상으로 흉민애기 완복창만이 나타남
- 치법: 중증에는 당귀용회환(간경의 실화에 사용), 경증에는 소시호탕

2) 어혈협통

- 병인: 장기간 기체 또는 타박손상으로 혈체나 어혈이 협하에 정체됨
- 특징: 자통, 통처가 한 곳에 고정됨. 환부를 누르면 통증이 심해지고, 야간이나 오후에 통증이 심해짐(→ 근데 꼭 그렇지는 않음)
- 치법: 시호사물탕 가 파어지제(도인 홍화 유향 몰약 현호색)

*유향 몰약은 진통 목적으로 많이 사용하지만, 냄새가 상당히 좋지 않음 주의

3) 담음협통

- 병인: 습사가 침습하거나 비허생담해서 발생
- 증상: 협력인통 해수 기급 녹녹유성(특징)
- 치법: 궁하탕(축수이음하는 효과가 뛰어나. 습대사 문제에 궁하탕을 많이 사용)

4) 식적협통

- 병인: 과식이나 과음, 고량후미 과다 섭취할 경우에 비위 운화기능을 잃어 발생
- 특징: 흉경으로 상충하는 듯 아프다(= 흉두꺼로 찌르는 듯이 아프다)
- 증상: 납매(밥맛없음) 흉민 오심구토. 식적이기 때문
- 치법: 소식도체, 소식청간탕
- 과식과 과로가 겹치면 한열이 나타나기도 함: 식적유상한
- 식적유상한에 도씨평위산 사용

5) 풍한협통

- 병인: 외감풍한으로 협통이 발생. 풍한은 화열한다.
- 특징: 외감증상이 나타남.
- 증상: 협통이 있으며 황열왕래 흥협고만, 인건, 목현, 이명, 불욕음식, 심번희구. 소양경증에 해당
- 치법: 소시호탕 사용

6) 건협통. 허증

- 증상: 허로증이 심하여 협하에 항상 일점의 통증이 있음.
- 어혈협통과의 차이점은 실증(어혈협통)과 허증(건협통)의 차이
- 치법: 팔물탕

2. 간실, 간허협통

1) 간실협통

- 병인: 정지울결, 폭노상간 등으로 소설실조해 나타남. 또는 간열이 유여해 발생
- 증상: 양협하통, 소복인통 (→ 이 두 개가 간실증을 의미)
분노를 자주하고, 수족이 번열하여 편하게 눕지 못한다(: 간기울결 때문)
- 치법: 당귀용회환, 소시호탕

2) 간허협통

- 병인: 오랜 병으로 정혈이 휴손되고 음액이 부족해지면 나타남. 또는 간화가 폐를 침범해 나타남
- 증상: 허증이므로 협통이 은은하게 아프고, 통증이 그치지 않는다.
목시불명, 심번, 두훈 (→ 혈허증).
인건, 해수(간화가 폐를 침범했을 경우 인건 해수), 선공(간허증)
- 치법: 간허는 주로 혈허로 나타나므로 사물탕에 가감하여 사용
좌협통에는 지궁산 우협통에는 추기산

제 4절. 임상적 고찰

- 협통은 장기의 기질적 질환의 한 증상
- : 간담도질환 심장 폐 비장 상행결장이나 하행결장, 피부에서 나타나는 대상포진, 늑간신경통 등이 해당
- 기울, 식적이 주로 나타날 수 있음

★ 협통을 일으키는 질환의 임상적 양상을 비교, 감별하시오(14)

- 협통을 일으키는 질환의 임상적 양상의 비교, 감별

급성간염	갑작스럽게 간장이 비대, 협통. 식욕부진 오심구토 피로감이 동반
알콜성 간질환	알콜성 간염, 알콜성 지방간. 간비대+옆구리가 빠근함, 권태, 복부 불쾌감
간경변	심장성 간경변의 급성 수동적 울혈* : 간비대 협통, 우상부 복통 *간의 수동적 울혈은 간은 이상이 없고 간정맥으로 나온 혈액이 하대정맥을 따라 심장으로 가는데, 심장의 어떠한 문제로 혈액이 들어가지 못하고 역류하는 것.
지방간	협통이 나타나지 않지만 급작스러운 지방 침착에서는 통증이 나타날 수 있음. 알콜과 관련이 높음
간세포암	협통 우상복부통, 복부 종괴, 복수 동반
담석증	협통 있고, 지속적 통증이 심하부에서 우상복부로 이동, 심하면 우측견갑부로 방사통
담낭염	우상복부통증과 협통이 동반. +) 담석증을 동반한 담낭염이 있을 때, Murphy's sign : 우협부 늑골 9-10에 손을 두고 흡기를 시키면 횡경막이 내려가면서 간과 쓸개가 내려와 통증이 유발됨. 통증으로 흡기가 멎음.
급성췌장염	심하부, 배꼽주위에서 나타남. 하복부로 방사통. 바로 누우면 통증 심해지고, 복직근 긴장 이완하기 위해 상체를 구부리거나 무릎을 굽히면 호전됨.

	+) 췌장염으로 인한 복부에서 나타나는 급성 통증을 빨리 멎게하는 방법은 달달한 음식. 사탕이나 초콜릿, 꿀물.
만성췌장염	좌우상대부에서 통증, 전흉부로 통증이 방사. 음주로 인한 경우 많음
대장질환	상행결장, 하행결장에서 발생
낮적혈구병(적혈구 형태이상)	
만성기관지염, 폐기종, 천식(호흡곤란 객담 천명 등)	
늑간신경통	일점통. 움직일 때 통증 심해지고 호흡 어려워짐
신결석	옆구리~서혜부 아래로 통증
신세포암	혈뇨, 복부종괴, 협통이 특징
신우신염, 협심증, 울혈성 심부전	
SLE 전신성 홍반성 낭창. 루푸스	

제 5장. 적취론

제 1절. 개요

- 痃癥현벽, 痞塊비괴라고도 한다.

積積	- 跡, 충적을 가리킴 - 담, 어혈과 같은 고형성분이 쌓임 - 유형의 병변
	- 유형, 고정되어 이동하지 않음, 통증이 일정한 부위에 있음 - 혈분, 장병, 병기가 길고 중병
聚취	- 緒(실 서, 나뉘질 서) - 한 군데 정해지지 않고 쉽게 흩어짐 - 유형의 병변이 됨
	(: 적보다는 무형에 가까우나 취 자체만 보면 유형의 병변이라 표현함) - 무형, 모였다가 흩어졌다 함, 통무정처(일정하지 않음) - 기분, 부병, 병기가 짧고 경병

- 서양의학적으로는 복강 내 있는 각종 암, 간비장의 종대, 장기능 문란, 기계성 장 정조(장폐색을 의미), 장결핵, 유문경조(유문폐색), 신장하수 등이 포함됨

제 2절. 병인병리

- 적취의 병인은 모두 기혈의 어체로 발생

기체혈허	칠정소상 기기불창하여 발생. 여성질환에 더 많음. 갑상선 질환, 유방 관련 질환
음식내상	오래되어서 발생 주식부절로 비양문화기능이 실조되어 습탁이 뭉쳐 습증담, 담이 오래되어 적취를 형성
한습응취	한기, 음식의 실조(습)으로 인해 적취가 발생
선천소인	- <영추 오변편> : 피부박이불택, 육불견한 사람들에게 적취가 있다. : 피부가 얇고 불택하고 육근이 단단하지 않은 사람에게 사기가 머무르는 것이 많다. → 영추에서 유전병, 선천적 소인을 언급 (소화기 종양, 신장 종양, 여성의 유방암도 가족력이 있음)

제 3절. 증치

- 적은 모여서 풀어지지 않고 취는 풀어지기도 함
- 적은 정기와 관련. 정쇠가 심함. 취는 병기가 비교적 얇다
- 소간이기화담/활혈거어이기 위주
- 어차피 오래된 병이니 두정연견하는 방법을 병행해야 한다.

1. 취증

1) 간울기체

- 주요증후: 복중에 氣聚기취하고 攻竄공찬*창통, 식취취산(모였다가 흩어졌다), 완협지간이 가끔 불쾌함

*공찬: 공격했다가 도망갔다가 하는 식으로 통증이 나타난다는 것

- 증후분석: 기(울기)와 한이 결취하여 취증이 형성됨. 공찬찬통하는데, 울기가 멎쳐진 것이 흩어지면 창통이 즉시 멈춤
- 치법: 소간해울 행기이취.

소요산, 목향순기산, 행기향소산 (간울기체로 인한 취증은 이기하는 것이 중요)

• 소요의 뜻 again

: 시경에서 나온 용어로, 이리저리 거닐다, 유유자적하게 뒷집지고 걷는 것을 말한다. 소요산의 약들이 불편감을 해소시켜준다는 의미이다.

2) 식체담저

- 주요증후: 복창, 협통, 변비, 소변황, 심하면 눌렀을 때 창통이 심해짐
- 증후분석: 비기가 불운하여 습담이 내생하고 기혈운행을 불창시켜 적취를 만듦
- 치법: 이기화담 소체통변. 정전가미이진탕

*식체담적이니까 이기소체 맞는데, 통변은? 변비 소변황 증상 때문

2. 적증

- 간기울결→기체혈어→정허어결(점점 심해짐)

1) 간기울결

- 주요증후: 협하에 덩어리가 있는데, 아직 부드러움(연이불견). 적증이므로 덩어리가 고정불이
- 증후분석: 정기가 리허하므로 덩어리가 연이불견. 덩어리가 고정되고 창통증도 한 곳에 머물러 공찬하지 않음(*공찬하는 것은 취증)
- 치법: 이기소담 활혈. 소적정원산(동의보감)

2) 기체혈어

- 주요증후: 적과가 명현하고 단단하면서 통증이 있는 것이 움직이지 않음.
면흑신수하고 소식핍력 시유한열 증상이 심해짐(= 간경화 말기증)
- 증후분석: 현저하게 증대된 것은 기혈응체 때문임. 면흑신수하더라도 허증으로 볼 수 없는 것은 기체혈어이기 때문이다.
- 치법: 활혈거어 행기소적
: 마르고 얼굴이 시커멓고 밥도 못 먹으면 허증인데,
본은 허증이라 하더라도 표에 실증이 심하게 나타나면 실증을 먼저 해결해야 함
- 처방: 당귀활혈탕(: 적취가 아니라 혈울에 사용하는 처방)

3) 정허어결

- 주요증후: 적과가 아주 단단하고 통증이 점점 격해짐.
면색이 위황하거나 검고, 식사 못하고 형체소수.
- 증후분석: 병세가 오래되어 나타나는 것이므로 중기가 많이 손상되고 비위운화 기능이 손상되었기 때문.
- 치법: 대보기혈 활혈화어
- 적증 후기에 황달, 고창, 축수, 녹혈 토혈 변혈은 위험증후라 본다

4) 간적증치

- 비기환 복령환, 식분환, 소적백출산 등
- 이런 약들로 실험을 해보면 암세포 생존율을 감소시키더라~

3. 대울증

- 울: 울결하여 발화하지 못한 것, 펴지 못한 것.
- 6울: 기울 습울 열울 담울 혈울 식울
- : 풍과 한을 언급하지 않은 것은 풍한이 울하면 열이 발생하기 때문
- 치법으로 순기를 우선, 울결하여 발월하지 못하는 것이 울증이기 때문
- 통치방은 육울탕
- 증상과 치료처방 정도 알아두기
- 통치방으로 육울탕 써도 된다

기울	- 증상: 흉부가 비만협통 - 처방: 목향조기산
습울	- 증상: 관절로 유주동통하고, 머리에 물체를 씌운 것 같고. 족중하고 음한을 만나면 더 심해짐(습이 한을 만나면 심해짐) - 처방: 삼습탕*
열울	- 증상: 구건설조 소변적탁 - 처방: 승양산화탕
담울	- 증상: 흉만하며 동작하면 천식이 급해지고 게을러짐
혈울	- 증상: 사지가 무력하고 밥을 잘 먹음. 소변이 임력하고 대변이 색황(대변에 출혈이 있음) - 처방: 당귀활혈탕
식울	- 증상: 혈울과 반대, 애기탄산하며 음식물을 싫어하고, 심하면 황달, 고창, 비괴 등 - 처방: 향사평위산

• 삼습탕

: 일절의 습증을 치료하는 약. 조습, 이기약들로 구성

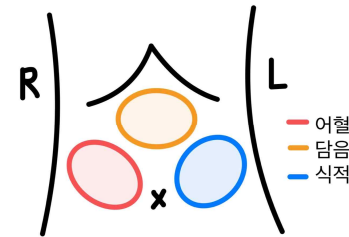
ex) 비가 와서 방이 눅눅할 때

1) 물 먹는 하마, 선풍기 틀기, 통풍 잘 되게 하기 → 삼습탕

2) 보일러를 틀어 열을 가해 습기를 말리기 → 승습탕(: 부자 계지 등 따뜻한 약)

4. 비괴와 적취의 소속부위

• 비괴와 적취의 소속부위



우측은 주로 식적,
좌측은 어혈(어적),
가운데는 담음

→ 교수님 case: 검사 이상 없는데 좌하복부가 반복적으로 아픈 환자에게 혈부축어탕을 사용하고 통증이 경감됨

5. 비괴증치

- 이동하지 않는 것은 癥징괴, 이동하는 것을 瘕가괴
- 이것만 언급하시고 PASS

6. 적취의 치법

- 공하제를 망용하면 진기가 손상됨
- : 공하제의 특징은 차가운 약재가 많다는 것으로, 많이 쓰면 우리 몸에서는 중한증(한에 맞는다)이 발생할 수 있음
- : 양약으로는 항생제, 소염제에 해당.
- : 소화기 약한 사람은 중한증에 걸릴 가능성이 높음.
- 위안이 발생하면 향사양위탕 등을 써서 중화시키기도 함
- 적취의 치법은 양정소적법.
- : 올려주는 양정, 내려주는 소적. 보법과 사법을 적절하게 배분하여 사용한다.
- 고량후미 끊고 노하지 말고 등등

제 7장. 노권상론

제 1절. 개요

- 만성피로증후군과 연관
- 노력과도로 손기되어 나타나는 내상병의 일종.
- 피로, 무기력, 발열, 한출을 주증상으로 함.

• 발열이 있는데 왜 노권상인가?

: 보중익기의 주치증에 심번이 들어감.

- 勞노: 지치도록 일을 하는 것
- 倦권: 피로

노동	지치도록 일을 하는 것 돈 벌면서 하고 힘들어도 해야 되고 사용하는 근육만 계속 사용
운동	적절하게 하는 것 돈 쓰면서 하고 힘들면 그만 하고 다양한 근육을 사용

7. 황달

제 2절. 병인병리

- 노권과다로 인해 내열이 발생하고, 기단천급하고 한출하고 기가 모손된다
- 모두 노권상에 해당, 보중익기탕 주치증에 해당.
- 동원 曰 희노의 부절제와 기거의 불규칙, 노역의 과다가 병인이다
- 주단계 曰 노역으로 인해 원기를 상해 부족지병이 된다

제 3절. 증치

- 이천 曰
전신무력하고 언어와 동작이 게을러지고, 오한 자한 사지번열, 심번불면 노상원기하여 소식하고, 기쇠한다.

제 4절. 치료

- <내경> 노한 거은 溫治온치, 손한 것은 보익한다.
: 온한 것은 養을 의미.
: 음식 잘 먹고 기거를 적당히 하고 청심하고 사려를 과하지 않게 하는 것
- 어떤 처방을 쓰나?
: 보중익기탕, 익위승양탕, 조중익기탕, 인삼양영탕
- 노력과도로 인한 무한증에는 보중익기탕을, 유한증에 황기건중탕을 사용한다.
: 근데 앞에서는 양허자한에 사용한다고 했는데?
이전 시간에 말했듯이 유한 무한을 너무 가려서 볼 필요가 없다는 것이다.
- 신력이 구상하여 기혈의 개상증에는 쌍화탕.
- 노권상 증상에 간질환이면 청열리습

★ 노권상과 방로상을 비교하라(14)

- 노권상과 방로상의 비교: 치료의 차이

노권상	방로상
내상발열증으로, 나타나는 증상은 비슷	
- 양기 하함 때문	- 양화의 상승 때문
- 보기해서 승양	- 자음해서 하강

제 5절. 노권상과 간질환

- 간질환에서 피로, 권태 등 노권상 증상들을 많이 호소함
- 증상: 전신무력, 언어동작이 게으르고, 사지연약, 표열자한 사지번열 등
⇒ 권태감, 피로, 허약감으로 요약.

- 노권상 범주에 급성만성간염이 포함될 수 있다.

급성기 간염	비특이적 전신증상, 소화기 증상. 황달이 나타나기 전까지 권태, 허약 → 노권상 증상과 일치
만성기 간염	주 임상증상이 피로감, 밥맛없음, 소화안됨

- 주관적인 증상 표현: 차트에 NRS VAS를 이용해서 기록해야 함
- 구체적 접근의 필요: 피로는 어떤 병에도 있을 수 있는 일반적 주소이므로 피로의 정도, 형태, 지속시간 등 구체적 접근이 필요함. 선행질환을 배제, rule out 시켜나아가야 함.
- 치법

간기능수치가 현저히 상승 수치가 크게 상승되어 있지 않으면서 병기가 오래되어 허증을 나타냄	청열리습 이담 안신, 개울 파적 행기 보기승양
--	------------------------------

→ 피곤해도 간기능수치가 상승되어 있으면 보법을 쓰지 말라는 말임

★ 만성피로증후군의 필수진단기준, 보조진단기준, 관련된 간허증에 대해 기술하라(10, 17)

제 6절. 만성피로증후군(CFS)

- 충분한 휴식에도 피로감을 느끼는 증상이 6개월 이상 지속될 때
- 일부에는 우울증, 신경증 불안감 등 정신질환을 갖고 있기도 함
- 피로감을 가장 많이 호소, 미열, 수면장애, 정신집중이 안되는 등의 증상
- 여자 > 남자의 4배

: 이유는 자가면역질환이 여성에게 더 많고, 피로 때문에 의사를 방문하는 이유가 많기도, 여성이 남성에 비해 육아 가사 등 생활환경에서 스트레스를 더 많이 받기 때문

- 진단기준

▶ 필수진단기준

임상적으로 진단되었고(간기능검사 등 검사상으로 이상이 나타나지 X),

- ① 설명되지 않는 새로운 피로가 6개월 이상 지속적 혹은 반복적으로 나타남
- ② 현재의 힘든 일 때문에 생긴 피로가 아니어야 한다. (설명되는 혹은 현재의 힘든 일로 인한 피로는 해당 X)
- ③ 휴식으로 증상이 호전되지 않아야 함
- ④ 만성피로 때문에 직업, 교육, 사회, 개인 활동이 증상 이전에 비해 실질적으로 감소해야 함

▶ 보조진단기준: 이 중 4가지 이상이 있어야 만성피로에 해당

- ① 기억력 혹은 집중력 장애
- ② 인후통
- ③ 경부 혹은 액와선 임파선 압통
- ④ 근육통
- ⑤ 다발성 관절염
- ⑥ 새로운 두통(頭痛)
- ⑦ 잠을 자도 상쾌한 느낌이 없음
- ⑧ 운동(혹은 힘든 일) 후 심한 권태감이 24시간 이상 지속

- 규칙적 생활, 적절한 방법으로 해소..

: 특별한 방법이 없다는 말임. 적절한 방법을 뇌네들이 잘 찾아 해라

• 만성피로 관련 간허증 (: 기출인데 수업은 안하셔서 19자료 넣어드립니다)

1. 간기부족

- 원인: 간의 승발기능이 부족 or 근맥이 실양
- 증상 : 관절불리, 억울담겁(抑鬱膽怯), 선공(善恐), 태타핍력(怠惰乏力), 맥세약

2. 간노증

- 간기부족과 유사 (만성피로증후군과 유사)
- 원인: 모려(謀慮)과도로 인한 학소(涸少), 다노상간(多怒傷肝) 등으로 인해서 발생
- 증상: 시력이 좋지 못함, 눈물을 흘림, 두려워 혼자 눕지 못한다 (恐懼 不能獨臥)

제 8장. 주상론

제 1절. 개요

- 음주의 과도로 인한 내상
- 술은 대열대독대습한 성질이 있음
- 좋은 술은
풍한을 방어하고 혈액을 선통하고 사기를 소감하고 인도약력*하는 효능이 있다.
- *인도약력 효능으로 주초 등 본초의 수치법에 사용
- 과도하게 먹으면 독기가 봉심하고 천장부협(옆구리가 썩음)

★ 주상에 대한 장중경, 소원방, 이동원의 견해를 기술하라(13)

장중경	- 과음으로 인한 황달을 주달이라 함. - 안구가 黃染황염, 소변황, 心中濃而熱심중농이열, 속이 울렁거리고 뜨거움, 음식 못 먹고 토하고자 한다
소원방	- 평소 음주를 즐기고 식곡이 부족해 술을 먹지 않으면 토하는 것을 주하라고 함 (= 현대의 알코올 중독증)
이동원	- 주상의 무형지기설을 주장 - 치법: 발산한출, 리소변. 갈화해성탕(의방집해) - 알콜로 나타나는 습을 상으로 발산, 하로 리소변 = 상하분소기습

★ 알코올 중독 test 중 DAGE에 대해 기술하라(10, 11)

• 알코올중독증 자가진단방법 CAGE

cut down	술을 끊어야겠다고 생각한 적이 있다
annoyed	음주로 타인에게 비난받은 적이 있다
guilty	스스로 음주 때문에 죄책감, 불쾌감을 느낀 적이 있다
eye opener	술을 마신 다음 날, 해장술을 찾게 된다

2가지 이상: 가능성이 있음 / 3가지 이상: 알코올 의존증

- 이외에도 AUDIT 설문지도 있음. 10가지 항목으로 점수를 합산하여 평가

제 2절. 증상

- 오심, 구역, 신혼변란, 홍민비색, 밥맛없고 소화안되고 소변불리, 신열, 오한, 두통, 설사

醉飽하여 入房하면	주기와 곡기가 상박하여 열이 중초에 응성하여 전신이 내열(상신=음허)하며 소변이 적습하게 되는 것
상부에서 담울	열에 의함, 술의 성질이 상승
하부에서 뇨삽	습으로 하부에 뇨삽을 일으킴
차가운 것을 먹으려 함	술이 습열한 성질을 가지므로, 폐가 번열하게 되어 寒涼物을 恣飲(차가운 것을 자꾸 먹으려)하게 됨

- 日淺할 때 嘔吐, 自汗, 瘡麻, 鼻鼾, 自泄 혹은 心脾痛 등이 발생
- 日久하며 病甚하면, 消渴, 黃疸, 肺萎, 內痔, 鼓脹, 失明, 哮喘, 勞嗽, 癰瘤
요런거는 국시에도 만나올거 같아요~라고 하심

제 3절. 치료

- 치법: 발산 한출 이노
- 처방: 갈화해성탕(가장 다용), 주증황련환, 대금음자

*갈화해성탕(의방집해)

*숙취에 많이 쓰는 약은 1) 갈화 2) 지구자(헛개나무)

*갈화를 많이 쓰면 약에서 비릿한 맛이 남

- 술 깨는 법

- ① 단계심법: 열탕으로 漱口(양치질)하여 치아의 주독 제거하고 大醉(만취)시에는 밀실(깜깜하고 바람 통하지 않는 곳)에서 열탕으로 수차례 세수하고 梳頭(수십회 머리를 빗으면)하면 술이 깬다
- ② 동의보감: 주식상이나 강권(억지로)으로 인한 주상의 경우 소금으로 치아를 닦고, 온수로 3차 정도 양치하면 快通한다

교수님 曰 위에처럼 해도 안 깬다. 적게 먹는 게 가장 좋겠조?

주불강권 객불고사: 주인은 손님에게 강권하지 말고, 손님으로 가면 주인이 권하면 사양하지 말라.

제 4절. 음주금기

- ① 계지탕을 쓰지 않는다.
(주객은 甘味를 좋아하지 않는다; 술 좋아하는 사람 단 것 안 좋아함)
- ② 탁주에 면을 같이 먹으면 땀구멍이 폐색 (교수님 曰 아님)
- ③ 면백한 사람(위장이 약한 경우 多)은 혈을 모손하기 때문에 多飲하면 안된다.
- ④ 三盞(석 잔)이상 먹지 말라. 傷五臟, 昏亂發狂
: 과음하면 빨리 토하는 게 상책(음주 후 30-90분 사이 혈중알콜농도가 가장 높으니 흡수되기 전 토하는 것이 좋으나 식도염의 위험이 있어 꼭 상책인 것은 아님)
- ⑤ 술 먹고 뛰거나 차, 배를 타는 것은 좋지 않다.
- ⑥ 취하여 入房하면 수명이 줄어든다. (신음허 유발)
- ⑦ 음주를 급속하게 하면 폐를 상할 우려가 있다

조금 먹는 것이 가장 낫겠죠?

제 9장. 기타 간병

제 1절. 두통

1. 간병두통

- 간병내동과 유사 (간양화풍, 열극생풍, 혈허생풍이 간병내동 유발)

① 간양상항 두통: 본허표실증 (이후 간양화풍이 됨)

증상	심하지 않고 은은한 통증. 주로 상부증상
치료	평간잠양. 오래되어 요슬산통, 신음부족을 겸하면 자양간신음

② 간화상염 두통: 본표개실증이므로 극열 (열극생풍이 됨)

증상	이명 이롱이 돌발적. 목적 면적
치료	청간사화, 청간탕

③ 간혈부족 두통: 혈허생풍

증상	현훈과 경미한 두통. 오후에 심해지는 경향. 안면이 창백
치료	자양간혈, 보간탕 당귀보혈탕

+) 기허두통은 오전에 심해지는 경향. 순기화중탕 사용

2. 뇌풍, 두풍

- 용어는 다르나 모두 풍사에 의해 나타나는 두통으로 크게 다르지 않음

3. 편두통

우측편두통	담음풍열로 인함 (실증)	이진탕
좌측편두통	혈허풍성으로 인함 (허증)	이진탕+사물탕

4. 육경두통

동의보감의 육경두통임. pass

5. 태음결음두통

- 증상: 양협창황 현훈 목불욕개(눈뜨기가 힘들) 뺨이 푸릇하고 어지럽고 말이 게으르고 신체침중 울울욕토(지속적으로 토하려 한다)
- 치료: 궁신도담탕 혹은 반하백출천마탕

6. 두풍선

머리를 흔드는 것

예후

- 대부분 좋아짐(90%)

임상적 고찰

- 두통의 대부분은 근육에서 발생하는 근긴장성
- 이차적으로 편두통으로 진행
- 대개는 신경성 긴장에서 유발됨
- 두통이 있다고 모두 CT, MRI를 찍을 필요 없고 이런 경우는 전체 두통의 5-7%밖에 안됨

제 2절. 현훈

- 단순 회전성 질환이 아니며, 현 훈 모의 증상을 모두 포함함

현	암흑, 눈앞이 깜깜
훈	회전, 머리가 빙글빙글
모	혼미, 머리가 멍/띵

1. 병인병리

- 대부분 허로 인함(90%), 담화로 실한 경우(10%)
- 주로 상실하허한 경우가 많다: 위가 실하니 많이 흔들리는 것 ▽이런모양!

상실	담탁, 풍화, 간양, 간풍의 작용
하허	간신음허, 심비의 기혈부족으로 나타남

- 병인병리의 요약

간양상항이나 간화상염	하간 曰 풍화로 나타난다. 섭천사 曰 간풍으로 나타난다.
기혈의 휴허	경약 曰 허로 인해 나타난다.
신정의 부족	
담습이 교저하여 일어남	단계 曰 담으로 일어남.

2. 증치 - 임상적 분류

1) 간양상항현훈_섭천사 간풍

- 본허표실증
- 증상: 목삽 두통, 안면홍조, 실번 실면 다몽(모두 음허의 증상) 수족심열 구고
- 치료: 양음평간잠양

- +) 간화상염되어 노기로 현훈이 심해지고

급조이로 면홍, 목적, 심신이 요란, 실면하면 풍화(하간)에 대한 설명임.

2) 기혈휴허현훈_경약 허증

- 증상: 면색창백, 피부 모발이 윤택X, 심계, 잠 못자고, 밥맛 없고
- 치료: 익기보혈. 귀비탕, 보중익기탕, 익기보혈탕
- +) 대병후나 출혈로 인해 기혈이 모두 허함

3) 신정부족현훈_경약 허증

- 증상: 신허. 신음허 or 신양허가 나타남
요슬산연 이명 유정 양위 눈앞이 어른거리고 도한 실면
→ 신양허에 치우치면 사지가 따뜻하지 못하고,
→ 신음허에 치우치면 내열이 발생하여 오심번열이 나타남.
- 치료

양허편향했을 경우	온보신양해서 우귀환이나 팔미지황환
음허편향했을 경우	보신진정. 좌귀음, 육미지황환

4) 담습교저현훈_단계 담음

- 증상: 현훈이 있으며 두중, 온몸이 무거움(습 때문) / 두창(담 때문) / 소화기 증상(습담)
- 치료: 거담화습. 반하백출천마탕을 사용

3. 임상적 고찰

- 현훈이라고 환자들이 다 어지럽다고 하지 않음
- 회전성(어지러움), 비회전성, 비틀거림, 무력감, 눈앞이 아른거린다, 아찔하게 넘 어지려는 실신, 머리가 텅 비거나 멍한 느낌(모) 등 모두 포함
→ 현기증, 실신, 불균형, 두중감 등등 여러 가지로 표현 가능

- 회전성과 비회전성으로의 분류

회전성 (현기증, vertigo)	중추성	전정신경핵 이상 (뇌종양, 소뇌질환, 뇌간허혈)
	말초성	전정신경, 세반고리관 이상 (체위성 현훈, 돌발성 현훈, 메니에르 병, 전정신경염)
비회전성	눈앞이 깜깜, 머리가 멍함 등을 모두 포함. 큰 문제X (과호흡, 부정맥, 과한 스트레스가 있는 경우)	

- 1) 현기증: 명확한 회전감각, 주위가 움직이는 느낌
- 2) 실신: 의식상실이 일어나려는 느낌
- 3) presyncope: 기립성저혈압. 오랫동안 쭈그리고 앉아있던 후 일어났을 때 나타나는 증상
- 4) 불균형: 대개 점점 나빠짐. 퇴행성 관절염, 불균형한 보행, 파킨슨 병이 해당
- 5) 두중: 현기성, 머리 속에서 현훈감각을 느낌. 공황, 우울증, 불안, 과잉호흡 등에 해당. 비회전성 현훈에 해당

2. 감별 진단

1) Caloric 검사

- 누워있는 상태에서 귀에 뜨거운/차가운 물을 떨어뜨리면 세반고리관이 반응해 안구진탕을 일으키는 것을 전기적으로 잡아내는 것
- 양성이면 현훈, vertigo라 진단

2) Rumbert 검사

- 두개내 병변의 유무 파악하는 검사
- 눈 감고 20초 세워두었을 때, 지나치게 흔들리거나 한쪽으로 쓰러지면 양성

2) Nysten-Barany 위치검사법

★ 현훈에서 nysten-barany의 위치검사방법을 기술하시오 (17)

- 1) 발을 뺀고 앉힌다.
 - 2) 목을 30도정도 뒤로 젖힌다. (→ 중추성이면 이때부터 어지러워 함)
 - 3) 뒤를 받친 상태로 눕힌다.
 - 4) 고개를 좌우로 돌려본다.
- (→ 중추성이면 이때 심한 어지럼증을 느끼고 상당 시간 지속됨
→ 말초성은 시간이 지난 뒤 어지러움이 나타나고, 금새 증상이 사라짐)

제 6장. 창만론 19는 수업 안했는데 우린 왜...

제 1절. 개요

- 복부만 창대하고 면목사지에는 부종이 없는 것
- 臌脹(부풀 고), 鼓脹(북 고), 蠱(뱀속벌레 고)라고도 함

<소문 복중론>	- 心腹滿, 旦食則不能暮食者 : 아침에는 밥을 먹을 수 있는데 저녁에는 밥을 먹지 못하는 자를 고창이라 함 : 곡창에 해당. 아침에는 양기가 올라와 식사가 가능하나 저녁에는 음기가 올라와 식사를 할 수 없다는 말
단계	- 창만을 비만과 구별 : 비만은 안으로 답답하다 느끼나(內覺痞悶), 겉으로는 증상이 없는 것(外脹이 X) : 창만은 안으로 답답하면서 밖으로도 뽕뽕한 것 - 부종과 창만을 감별 : 부종은 음식을 평소와 같이 섭취하나 창만은 섭취 X

1) 창만의 원인

- 비기가 극허한 것
- 칠정에 의한 내상, 육음(습)에 의한 외침, 음식실절, 방로과도로 비기가 손상을 받아 수곡을 운화하지 못해 습이 생겨 주로 중초에서 뽕뽕하게 나타남.

2) 서양의학적

- 위장의 심한 가스(기창), 만성간경변증이 복수를 형성하는 경우(수창)에 해당

제 2절. 병인병리

1. 황달 적취 등이 오래되어 고창이 발생

- 습열 때문. 오래되면 비위를 손상시키고 기혈이 응체되어 만들어짐.
- 적취는 기울과 담어응결에 기인해, 수습정취가 일어나 만들어짐.

2. 흡혈충에 감염된 후 치료시기를 놓쳐 만기에 이름

3. 음주과도 음식부절로 비위를 손상

- 1) 비기가 허해 비주승 위주강이 안되어
수습의 탁기가 중초에 머물러 청양불승, 탁음불강,
- 2) 간의 조달기능을 상실하여 기혈이 울체불행,
- 3) 신기가 부족해 대사기능이 불리해져 수곡이 배설되지 못해 생긴다.

⇒ 간 비 신 3가지가 창만을 일으키는 주 장기이다.

4. 정지의 울결과 정기의 불창

- 비위 운화기능 떨어져 창만 일으킴.

→ 병리변화의 요점은 “처음에는 간비가 손상을 받고, 마지막에 신이 손상을 받아 창만을 일으키게 된다는 것”

제 3절. 증치: 점점 심해지는 과정이라 이해

초기에는 손으로 누르면 柔軟(유연)하다가 점점 단단해지고, 심하면 피부에 청근이 노출되고(메두사 머리, caput medusa), 배꼽이 돌출됨
면색이 위황하다 점차 검은색으로 변하고, 혹은 황달이 나타나며 전홍부, 경부, 뺨, 손등에 지주상혈관종(거미혈관종)*이 나타남.
더 심해지면 형체가 바짝 마르고 협하에 적괴가 보이고 대변비결 소변단소 코피, 치루출혈, 더더 심해지면 의식이 혼미(hepatic coma)해지고 구혈 변혈 토혈 등의 위급한 증후가 나타난다.

*지주상혈관종: 가운데 점이 있고 주변으로 퍼지는 듯한 모양, 거미의 몸체처럼 생겼다. 또는 성상혈관종이라고도 함.

- 변증에 먼저 허실을 변별

정기가 실할 때	행기 소적 축수 파어로 표치
정기가 허해지면	양간 건비 익신으로 본치
오래되어 정기가 손상되고 사기도 옹저	본허표실하면 부정거사

1. 칠종창만

- 대부분 생간건비탕을 주치방으로 함
- 특징적 증상만 알면 됨

1) 한창 寒脹	토리吐利, 췌냉증	생간건비탕+ 육계 건강
2) 열창 熱脹	음식여상 복종창만	생간건비탕_ 시호 황금
3) 곡창 穀脹	불규칙한 식사로 인한	평진건비탕(평위산+이진탕+소도지제)
4) 수창 水脹	록록유성 정충 천식	생간건비탕+ 죽여 맥문동 록록유성(배에서 소리)이 심하면 궁하탕
5) 기창 氣脹	칠정울결로 신체종대, 사지 마르고 안색이 흑색, 협통	생간건비탕+ 지각 빈랑
6) 혈창 血脹	상태가 안 좋음 변흑(혈변), 협부와 소복 창만, 복수, 전신에 혈선(메두사머리, 지주상혈관종)나타남	생간건비탕+ 지유 형개 당귀
7) 고창 蠱脹	복부만 창만하고 사지는 말라 거미와 같은 형상	생간건비탕+ 지유 형개 당귀 도인

고창은 잘못나왔네? 하고 설명 건너뛰심 (?)

2. 실창, 허창

- 실창은 陽熱病. 易治
- 허창은 陰寒病. 難治

1) 실창

기체습저	증상	단단하지 않고 험하에 창만 혹 동통 /습저로 인해 음식감소, 식후작창, 애기불쾌
	치료	소간 건비 이기
열울혈어 (혈창과 치료법 동일)	증상	복부견만, 단단함 /혈어로 협복자통, 지주상혈관종이 나타남. 음식여상, 심하 면 얼굴이 검어짐 /열울로 구순자적, 변열구건, 소변단적 대변비결
	치료	청열리수 활혈화어 (생간건비탕+ 지유 형개 당귀)

- 축수하행하는 약을 너무 많이 쓰면 비위를 공벌해 중한증이 생길 수 있다.

2) 허창

비신양허	증상	조관모급. 아침에는 식사를 원활히 하고 저녁에는 잘 못함. 곡창의 증상, 비기가 허할 때 양허 증상으로 피곤, 외한, 사지한랭 비기가 허해 습이 있으니 하지 부종, 소변단소 면색이 창황, 혹은 교백(희다)
	치료	건비온신 화기행수
	치방	생간건비탕 + 등심* 육계 건강 *등심은 차가운 약인데? 소변단소를 없애기 위함
간신음허	증상	상황이 좋지 않음. 복대견만. 심하면 정맥이 노장(메두사 머리). 면색이 검어지 고 입술이 붉고 구조심건. 출혈이 나타나는 것은 음허내열 이 심해져 혈열망행하기 때문. 소변단적
	치료	자양간신 양혈화어

- 병세가 돌변해 대량의 토혈 하혈 등 위급증상이 나타나면 서각지황탕으로 구급
처치를 한다. *교수님ㄷ 토혈은 식도정맥류출혈로 이때는 박하전원을 사용

- 음식섭취는?

: 일반적으로 저염식 - 염분이 많으면 복부에 수분 저류가 많이 되기 때문

: 요량이 더 줄면 무염식

: 복창이 사라지면 무염식에서 저염식으로

3. 창만통치법

- 補中行濕利水하는 약에 소도제를 겸해서 사용한다.

제 4절. 예후, 금기

1. 예후 이렇게 있다는 정도 알아둬라

1逆	복창 신열 맥대
2逆	복명 복만, 사지청랭, 설사, 맥대
3逆	복부 대창, 사지말단이 청냉, 형육이 탈락, 설사가 심
4逆	복부창만, 변혈, 맥대하며 때때로 끊어짐

2. 금기

- 소금 젓갈을 단절, 짜게 먹지 마라
- 사려와 망상을 피하라

제 5절. 고창증

- 장관 내에 과량의 가스로 인한 복부외창을 말함
- 음식으로 가스가 많이 생기거나, 생긴 가스가 잘 흡수되지 않는 질환, 혹은 과다
한 공기를 삼킬 때 발생

~~복수의 기전 발표, 메두사머리 및 지주상혈관종 사진 보여주고 수업 끝~~